SOPORTE DE AYUDA PARA EL ESTUDIO UF0128



U.F. 0128:

Apoyo en la organización de actividades para personas dependientes en instituciones.

UNIDAD FORMATIVA 2: APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES (UF0128; 70 horas)

Objetivos

- Definir el proceso de desarrollo de intervenciones dirigidas a cubrir las AVD de las personas, potenciando la mejora o el mantenimiento de la autonomía.
- Identificar los niveles de autonomía de los dependientes relacionándolos con la cobertura de necesidades de atención básica que permitan adaptarse a los protocolos de actuación.
- Explicar los procedimientos que fomenten la participación de las personas usuarias del centro sociosanitario.
- Reconocer y valorar la forma de acompañamiento en las AVD

Contenidos

1. Participación en la preparación de actividades en instituciones sociales

1.1.- Protocolos de actuación y seguimiento de los mismos.

Los protocolos de actuación describen el proceso en la atención asistencial de la persona usuaria dependiente en una institución con objeto de secuenciar, temporalizar y adecuar los recursos materiales y humanos necesarios. Estos deben indicar:

- qué hacer, por ejemplo “realizar el aseo”
- los recursos humanos, esto es, qué profesionales están implicados en la actuación
- para quién se hará, esto es, a qué usuarios está dirigida la acción
- Cómo realizar la actuación, esto es, cuáles son los pasos a realizar.
- La temporalización, esto es, cuándo se realizará la acción, en qué fases, cuánto durara
- El material específico a usar en las intervenciones.

Los protocolos son necesarios para homogeneizar (hacer de la misma manera) la ejecución de las tareas, de tal forma que todos los profesionales tengan una forma de trabajo similar y reconocible y evitar la arbitrariedad de los diferentes profesionales.

Los protocolos más habituales son:

1. PROTOCOLO DE ACOGIDA al que nos hemos referido en el apartado 2 de la UF 0127 del MF 1016.

2. PROTOCOLOS DE APOYO Y AYUDA EN LA REALIZACIÓN DE LAS AVD como por ejemplo,
   2.1. Protocolo de higiene de personas usuarias.
   2.2. Protocolo de caídas de usuarios.
   2.3. Protocolo de actuación ante incontinencias (urinaria y fecal).
   2.4. Protocolo de vestido.
   2.5. Protocolo de alimentación
   2.6. Protocolos de actividades ocupacionales.
   2.7. Etc.
3. Programa de intervención terapéutica. como por ejemplo,
   3.1. Protocolo de administración de medicación a personas usuarias.
   3.2. Protocolo de actuación ante úlceras y lesiones por presión.
   3.3. Protocolo de medidas de contención física a usuarios.
   3.4. Protocolo de vacunación
   3.5. Protocolo de primeros auxilios
   3.6. Etc.
4. Protocolo de duelo
5. Protocolo de intervención con familias
6. Protocolo de intervención ambiental
7. Protocolo de colaboradores
8. Etc.

Todos ellos se irán desarrollando en las diferentes UF de los MF de esta formación, pero en la página http://www.infogerontologia.com/pgi/index6.html podéis acceder a muchos de ellos.

Parte de los protocolos es el seguimiento de las intervenciones programadas. Este se efectúa a través de registros, cuyo objetivo es asegurar una mejor calidad en la atención a las personas usuarias porque se evite la duplicación de acciones, se registran las incidencias, o se evita que a consecuencia de un cambio de turno por ejemplo, quede un usuario sin asistencia.

Algunos de los registros más habituales son:

- Registros de Historia Integral de la persona usuaria (clínica, de enfermería, social, psicológica, etc.).
- Registro de Evaluación Funcional y Cognitiva, registros de conducta...
- Registro del Plan de Cuidados Individualizado.
- Registro de Seguimiento del Plan de Cuidados Individualizado.
- Registro de Seguimiento de la Participación en el Programa de Actividades.
- Registro alimentación (dietas, menú, cuanto ha comido...).
- Registro de Actividades de Mantenimiento de la Higiene personal.
- Registro de la medicación (distribución de tomas; fechas de inicio y final de la prescripción...)
- Registro de Control de Constantes y Balance Hídrico.
- Registro de Tratamientos de Enfermería.
- Registro de Caídas

- Registro de de incontinencia cambios de pañal...
- Registro de cambios posturales
- Registro de personas usuarias con Úlceras por Presión, indicando causa originaria, tratamiento, y fecha de aparición y de curación.
- Registro de Visitas, indicando el nombre del residente que recibe la visita, la vinculación de los visitantes, y la hora de entrada y salida, la respuesta de la persona usuaria...
- Registro-Libro de Incidencias.

Al finalizar cada turno de trabajo, o la atención según sea la actuación a registrar, el profesional de atención sociosanitaria rellenará individualmente la hoja de seguimiento de cada usuario. Como ejemplo tenéis la siguiente tabla:

PLANIFICACIÓN SEMANAL Y REGISTRO DE LA ATENCIONES A LAS AVD

Apellidos y nombre:									Habitación:
		LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	Observaciones e incidencias
Higiene	Diaria								
	Lavado de pelo								
	Ducha/baño								
	Afeitado								
	Otros								
Alimentación (B)ien (M)al	Si precisa ayuda								
	Dieta normal								
	D. Blanda								
	D. Astringente								
	D. Diabética								
	D. Hiposódica								
	Otras dietas								
Continencia	Si/No								
	Acomp. Al WC								
	Cambio de pañales								
Cambios posturales	Mañana								
	Tarde								
	Noche								
Sueño: mal (M) o regular (R)									
Observaciones e incidencias:									

Corte de uñas								
Limpieza silla o andador								

Periódicamente, cada institución decide con qué frecuencia, diaria, semanal..., se examinan los registros por parte del equipo interdisciplinar. De las conclusiones que se extraen se realizan las modificaciones oportunas a los programas existentes, o se anulan o se implantan nuevos. Es por esto importante que el personal de la atención sociosanitaria cumplimente con precisión y rigor estos registros, ya que son la base de posteriores intervenciones.

1.2.- Participación del usuario en las actividades diarias de la institución.

La participación activa de la persona usuaria es fundamental porque:

- Favorece la autonomía
- fomenta hábitos saludables para con sigo mismo
- potencia las relaciones sociales

Lo habitual es que la persona usuaria no participe en la organización, los horarios y las actividades. Son planificadas por los profesionales de la institución y no dejan margen al usuario.

Esta filosofía potencia la dependencia porque limita el comportamiento autónomo de las personas usuarias y por lo tanto, será importante que las mismas y las familias participen en la medida de lo posible en la organización.

En definitiva, para lograr una participación activa del usuario en la institución de atención a personas dependientes, será preciso que la persona usuaria, la institución, el equipo interdisciplinar y las propias actividades, se interrelacionen de manera adecuada y cumplan los siguientes requisitos:

- Por parte de la institución se ha de permitir que los usuarios puedan participar de forma activa en las actividades del centro y en la organización de las mismas. La dirección del centro debe impulsar que se formen órganos de participación de los ingresados (asambleas de residentes y grupos de familiares). La creación de estos órganos no sólo favorecerá la participación de los usuarios en las actividades que se desarrollen en la institución, sino también su implicación en la toma de decisiones sobre la organización de las mismas.
- Equipo interdisciplinar: debe tomar en cuenta a la situación real de los usuarios, sus necesidades, sus gustos y apetencias adaptando los programas ya diseñados a las necesidades concretas de cada uno de ellos. No debe generalizar y a de atender a cada usuario en función de sus necesidades. Así mismo se debe permitir a la persona usuaria, que progresivamente, vaya tomando decisiones por sí mismo, favorezca la participación en las actividades

que se realicen en el centro y sea capaz de realizar de manera autónoma todas las actividades posibles. Todo esta es posible:
  - Evitando tomar decisiones por los usuarios,
  - Pidiendo su opinión,
  - Manteniendo una actitud de escucha atenta y activa,
  - Adaptando la información a los usuarios,
  - Evitando el paternalismo y la sobreprotección.
  - Evaluando y escogiendo las formas más adecuadas de aprendizaje para cada persona.
  - Estando atento a las necesidades del usuario y a las manifestaciones de las mismas.
  - Brindando apoyo emocional al usuario.
  - Teniendo una actitud de flexibilidad: modificando los objetivos para convertirlos en asequibles o descomponiéndolos en otros más sencillos, creando oportunidades de éxito
- La persona usuaria debe conocer la realización de la actividad para poder participar en ella: horario, lugar donde se lleva a cabo y personas que intervienen. Se usarán tablones de anuncios, informando personalmente al usuario, etc. Además, es importante recopilar información sobre la opinión del usuario sobre la actividad una vez se haya realizado, así como sobre la organización general del centro mediante encuestas de satisfacción. La persona residente ha de tener la capacidad, la habilidad o los conocimientos necesarios para poder realizar la actividad. Por ello, es fundamental potenciar esas capacidades fomentando el aprendizaje pero también adaptar las actividades a las capacidades de los usuarios.
- La actividad debe satisfacer los deseos, gustos y preferencias del usuario, es decir, éste tiene que querer realizar la actividad y deben tener una serie de características para fomentar la participación, adaptadas y específicamente diseñadas a los usuarios a los que van dirigidas, teniendo en cuenta sus características, necesidades y preferencias.

1.3.- Autonomía del usuario

Antes de indicar los aspectos fundamentales de la autonomía de l persona usuaria veamos qué se entiende por autonomía y qué por su antónimo, dependencia.

La Ley de dependencia, define la autonomía como “la capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias así como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria”.

La misma ley define dependencia como “el estado permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con

discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal".

El profesional en atención sociosanitaria deberá ser capaz de identificar los niveles de autonomía de personas dependientes, relacionándolos con la cobertura de necesidades de atención básica que permitan su adaptación a los protocolos de actuación establecidos en la institución social y por el equipo interdisciplinar.

Por otra parte la autonomía está supeditada a las propias capacidades, competencias y de si el entorno en el que vive facilita o dificulta el desarrollo de esas capacidades



En las personas dependientes se dan una serie de problemas o carencias que pueden llevar a tener dificultades para la realización de alguna Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) o las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD) de manera independiente. Si no se compensa estos problemas o carencias, la persona sufrirá una incapacidad funcional para llevar a cabo dicha actividad.

Uno de los objetivos básicos en las instituciones sociosanitarias de atención a personas dependientes es lograr el desarrollo y potenciación de las capacidades que permiten la autonomía personal. Es por ello preciso trabajar mediante técnicas de aprendizaje y entrenamiento de los hábitos de autonomía personal tanto para lograr la autonomía en las ABVD como para lograrla en las AIVD.

Autonomía en las actividades básicas de la vida diaria y en las actividades instrumentales de la vida diaria..

Las ABVD son actividades básicas relacionadas con el cuidado personal de uno mismo (vestirse, arreglo personal, comer, control de esfínteres, uso del servicio comer) y con el funcionamiento físico (andar, movilidad en el interior del domicilio) y mental básico, que se ejecutan de forma cotidiana y cuya realización es imprescindible para que la persona viva de forma autónoma y adaptada a su entorno.

Las AIVD son actividades más complejas que las ABVD, importantes para mantener un funcionamiento normal en la vida para las que se requiere un nivel de autonomía personal mayor, pero no son básicas para el cuidado personal. Estas actividades incluyen, telefonear, realizar tareas domésticas (limpiar, cocinar, lavar ropa, etc.), manejar dinero, transporte.

El grado de autonomía está condicionado por los siguientes factores:

- Factores físicos:
  - Deterioro de los sistemas biológicos orgánicos (por ejemplo, el sistema cardiovascular).
  - Problemas físicos relacionados con la movilidad y la ausencia de fuerzas que pueden desencadenar accidentes y caídas.
  - Limitaciones sensoriales.
  - Enfermedades crónicas (p.ej., la osteoporosis).
  - Uso de fármacos (polifarmacia).
  - Edad.
- Factores psicológicos:
  - Trastornos mentales (p.ej., depresión, Alzheimer).
  - Factores de personalidad.
  - Nivel educativo.
  - Factores económicos.
  - Factores contextuales como el ambiente físico, nivel de estimulación, control del ambiente.
- Factores sociales: interrelaciones, expectativas, estereotipos, modelos sociales del entorno y sobreprotección.

Para potenciar la autonomía tanto en las ABVD como en las AIVD tenemos que según el Libro Blanco de la Dependencia, entre las estrategias para la prevención de la dependencia destacan:

- Promover hábitos de vida saludables.
- Mejorar la eficacia de los sistemas de atención de la salud.
- Tratamiento precoz de las enfermedades crónicas.

Para determinar el grado de autonomía en las ABVD y las AIVD existen diferentes escalas. Entre las más habituales tenemos:

Para las ABVD:

- ÍNDICE DE BARTHEL O DE CLASIFICACIÓN FUNCIONAL O DE AVDB: Consta de 10 ítems. Ocho grupos de actividades (alimentarse, lavarse, vestirse, aseo personal, uso de retrete, transferencias del cuerpo, deambulación y dificultad para subir y bajar escaleras) y dos funciones corporales (deposición y micción). La puntuación máxima es de 100, que nos indicaría que no existe dependencia y la mínima es 0, que nos indicaría máxima dependencia.

- ÍNDICE DE KATZ: Consta de 6 ítems, que son: baño, capacidad de vestirse, uso del retrete, movilización, continencia de esfínteres y alimentación. Dando la posibilidad de añadir "otro" no especificado. Para su valoración se utiliza una graduación de ocho niveles desde A (mínima dependencia) hasta G (máxima dependencia).
- ESCALA DE LA INCAPACIDAD FÍSICA DE CRUZ ROJA: Recoge de forma global dos grupos de actividades (la marcha y los "actos de la vida diaria"), la función corporal continencia y la necesidad de cuidados de enfermería, graduándolos en seis niveles de 0 (independiente) a 5 (máxima dependencia)

Para las AIVB, aunque existen numerosos métodos para la evaluación de estas actividades, el más utilizado es la ESCALA DE LAWTON Y BRODY, también denominado ÍNDICE DE LAWTON O AVDI. Para la evaluación en mujeres, consta de 8 grupos: capacidad para usar el teléfono, hacer compras, preparación de comida, cuidado de la casa, lavado de ropa, transporte, control de medicación y capacidad de encargase de sus finanzas. En los hombres sólo se reconocen cinco grupos: capacidad para usar el teléfono, hacer compras, transporte, control de medicación y capacidad de encargarse de sus finanzas. Cada grupo se subdivide en cuatro o cinco ítems según la gravedad y la puntuación oscila de 8 (máxima independencia) a 0 (máxima dependencia) en mujeres; y de 5 (máxima independencia) a 0 (máxima dependencia) en hombres.

1.4.- Acompañamiento en las actividades de la vida diaria de la persona usuaria según instrucciones del profesional responsable.

El profesional en atención sociosanitaria deberá ser capaz de reconocer y valorar la forma más adecuada de efectuar el acompañamiento al usuario en las actividades de la vida diaria, de modo que dicho acompañamiento se lleve a cabo cumpliendo las instrucciones emitidas por el profesional responsable.

Del mismo modo, el cuidador tendrá en cuenta las características e intereses del usuario para la realización de actividades, atendiendo a las instrucciones del equipo interdisciplinar con el objetivo de dar una correcta respuesta individualizada.

Como profesionales debemos tener en cuenta que una tarea de gran importancia para el profesional en atención sociosanitaria durante su labor de acompañamiento es descubrir los aspectos más estimulantes para cada usuario, de forma que éste mantenga una actitud activa y participativa.

Es necesario mencionar que el hecho de relacionarse con otras personas usuarias mejorará la integración del usuario en la institución y le ayudará a compensar o superar problemas de negatividad ante otras actividades, por desajustes afectivo-emocionales, deterioros cognitivo-conductuales, o limitaciones psíquicas o físicas.

Para la adecuada realización del acompañamiento en las Actividades de la Vida Diaria del usuario, el cuidador procederá teniendo en cuenta las siguientes pautas de actuación:

- Valorar las posibilidades de colaboración y potencialidades del residente; sus gustos, preferencias e inquietudes.
- Sondear y tener en cuenta sus propuestas, si es posible, procurando incluirlas en la programación de actividades, ofreciéndole aquéllas que más se adecuen a sus necesidades y explicándole los beneficios que le reportará su participación en ellas.
- Utilizar la empatía, intentando comprender las causas de la negatividad y la no-participación, apoyando, estimulando y reforzando positivamente al usuario.
- Ser constantes ante su falta de colaboración y no desanimarse hasta conseguir el máximo grado posible de actividad, haciéndole un reconocimiento especial cuando comience a participar en las actividades del centro.
- Buscar la implicación de otros profesionales que expliquen al usuario los beneficios terapéuticos de una actitud participativa e intentar involucrar a los familiares para que les motiven y convenzan de las ventajas de mostrarse activos respecto a la vida del centro

SOBRE TODO tener en cuenta que la asistencia del profesional sociosanitario debe de ser de realización de la actividad cuando el usuario no pueda llevarla a cabo por sí mismo, .de apoyo en la realización de la actividad cuando el usuario precise ayuda para llevarla a cabo y de supervisión en la realización de la actividad cuando el usuario pueda realizarla por sí mismo.

Además de participar en las actividades establecidas en su plan de cuidados individualizado, la participación del usuario podría extenderse también a:

- Las actividades generales de organización del centro: colaborando en la redacción y modificación del reglamento de régimen interno, de los estatutos, en la organización de sus rutinas diarias (horarios de entrada y salida, menús, horarios de comidas, etc.).
- El planteamiento y organización de actividades de ocio y culturales en las que desearía participar.
- La colaboración en algunas actividades domésticas: cuidando del jardín, arreglos de ropa, actividades auxiliares de cocina, etc.

1.5.- Información a los personas usuarias para el desarrollo de las actividades:

Si la situación ideal de funcionamiento es aquella en la que la persona usuaria participa, es evidente que previo a la participación está el conocimiento de la actividad, esto es, debemos dar una información adecuada sobre dichas actividades: horario en que se realizan, lugar y personas que intervienen, etc.

La información puede ser trasmitida con antelación suficiente a través de carteles, pero el profesional de atención sociosanitaria la complementará, informando personalmente.

En líneas generales, podemos decir que el profesional de atención sociosanitaria, a la hora de informar a los usuarios para el desarrollo de las actividades que se realizarán en el centro, deberá tener en cuenta lo siguiente:

- Expondrá el comienzo de la realización de la actividad: «Buenos días, es hora de vestirse».
- Comentará las fases de la actividad, explicando en todo momento al usuario, según sus características, qué hay que hacer. Si plantea dudas o no puede hacerlo por sí mismo, se le irán dando pautas de actuación, narrando lo que se está haciendo para ayudar al usuario a conocer lo que se hace, el orden y permitir de esta manera su colaboración: «Ahora hay que ponerse la chaqueta. Primero, esta manga. Ahora, la otra. A continuación, vamos a abrochar los botones».
- Utilizará un lenguaje sencillo, de fácil comprensión, con frases breves y claras. Asimismo, empleará el lenguaje no verbal con aquellas personas con discapacidades sensoriales: uso de pizarras, tableros de comunicación, comunicación mediante sistema braille, etc.
- Se empleará siempre un tono tranquilo y se motivará al usuario para que participe

Características e intereses de las personas usuarias.

El modo en el que nos debemos dirigir a la persona usuaria es cierto que tiene unas características generales como se ha citado en la introducción de este apartado pero también hay que tener en cuenta los diferentes problemas que éstos pueden llegar a tener a la hora de satisfacer sus necesidades. Por ello, tendremos que tener presente los distintos tipos de usuarios:

- La discapacidad física, psíquica o sensorial puede suponer una situación de dependencia para realizar una actividad
- La enfermedad mental puede generar la alteración de la percepción, los sentimientos, los pensamientos, la conducta y la adaptación al medio en que la persona vive y que, cuando se trata de un trastorno mental severo, puede provocar situaciones de dependencia.
- El envejecimiento puede producir una serie de cambios biológicos, cognitivos y psicosociales (disminución de la memoria, de la capacidad visual y auditiva, del número de neuronas y neurotransmisores, de la masa muscular, y del número de piezas dentales; y un aumento de la incontinencia urinaria y del riesgo de caídas, del aislamiento por pérdida de seres queridos, de la irritabilidad, etc.) que lleven a la persona a situaciones de dependencia.
- Según el proceso de la enfermedad por el que estén pasando, algunos usuarios pueden perder en parte o totalmente su autonomía personal.

- Hay actitudes en el usuario que denotan algún tipo de alteración que deben de ser percibidas como señales de alerta, por el profesional sanitario en el desarrollo de la actividad. Las más comunes son:
  - mutismo o aislamiento.
  - Inquietud o agitación.
  - Cambios radicales en su humor.
  - Comportamientos extraños o difícilmente explicables.
  - Alteraciones de comportamiento con respecto a otros residentes o al personal del centro.
  - Mayor agresividad.
  - Insuficiente higiene personal.
  - No aceptar la ayuda necesaria para realizar las actividades básicas de la vida diaria.

Incidencias y respuesta a las mismas.

Las posibles incidencias o circunstancias que obstaculizan el desarrollo de las intervenciones y el logro de los objetivos perseguidos, están las actitudes negativas en los usuarios, las cuales pueden dificultar la realización de cualquier actividad. En estos casos, es indispensable que el profesional en atención sociosanitaria comunique al equipo interdisciplinar la incidencia detectada.

Para ello, podrá hacer uso de los documentos de registro establecidos a tal efecto y, en todo caso, dejará constancia en el Libro de Incidencias de la institución mediante la cumplimentación de la Hoja de Incidencia correspondiente (ver apartado 1.1 de esta unidad).

Una vez comunicada al equipo interdisciplinar, éste determinará qué intervención realizar. Puede estimarse como necesario el uso de la motivación para reorientar la actitud del residente, lo que hace aconsejable aplicar algunas técnicas para modificar su conducta y motivarle.

Las técnicas de modificación de conducta tienen como objetivo mejorar el comportamiento de las personas a través de estrategias y procedimientos para conseguir una mayor frecuencia en una conducta adaptativa que ya existe, o su perfeccionamiento; la adquisición de una conducta nueva deseable; o la reducción de la frecuencia de aparición o eliminación de una conducta no deseada.

Una exposición más detallada de estas técnicas se recoge en el apartado Procedimientos y Estrategias de modificación de conducta del la Unidad Formativa 2 del Módulo 4.

2. Organización de actividades en instituciones sociales

El profesional de la atención sociosanitaria cuenta entre sus quehaceres el colaborar en la organización de actividades, así como en garantizar el nivel de calidad de los servicios prestados y la satisfacción de los usuarios. Su cometido es el de:

a) Comprobar, antes de realizar la actividad, las condiciones de seguridad y accesibilidad de los espacios para garantizar la agrupación de éstos en función de sus características personales, facilitando la disponibilidad de los recursos humanos y la existencia y puesta a punto de materiales y ayudas técnicas (se ampliara esta información en el módulo 3 en los apartados Tipos de ayudas técnicas y tecnológicas para la vida cotidiana y en de Ayudas técnicas para la deambulación, traslado y movilización en personas dependientes)
b) Tener en cuenta las características e intereses de los usuarios para la realización de actividades, siguiendo las instrucciones del equipo interdisciplinar que permitan dar una respuesta individualizada.
c) Comunicar al equipo interdisciplinar cualquier incidencia observada en el orden y el estado de los materiales, con el fin de adoptar las medidas oportunas para su resolución.

2.1.- Protocolos de actuación.

Para elaborar los protocolos y registros e introducirlos en el trabajo diario, es necesario que los profesionales del centro trabajen en equipo, creando el equipo interdisciplinario. Los protocolos y registros han de ser prácticos para todos y tienen que adaptarse a las necesidades y costumbres de cada centro, de los usuarios y del mismo equipo de profesionales.

No existen modelos de protocolos excelentes y es por ello que el equipo interdisciplinar ha de elaborar sus propios modelos, que han de ser dinámicos y adaptados a las características del momento concreto en que se encuentra el centro y efectuar una valoración, cambio y/o mejora periódica

ESQUEMA A SEGUIR PARA ELABORAR UN PROTOCOLO

Definición:	Concretar el tema del cual hablamos

Objetivo:	Explicar cual es la finalidad del protocolo (prevención, tratamiento o actuación hacia el residente).

Población a quién va dirigido:	Es un protocolo aplicable a todos o a algunos de los residentes (mencionar cuales).
Profesionales implicados:	Mencionar qué profesionales actuaran con este protocolo.

Descripción de la actuación	Cuales son los pasos a seguir (descritos siguiendo un orden). Recordar que si el protocolo es de prevención se tiene que hacer referencia al sistema a utilizar para detectar el residente de riesgo (como por ejemplo en protocolos de lesiones por presión, incontinencias...) Será necesario también mencionar las medidas de prevención y tratamiento o actuación de los profesionales.

	Hacer constar de forma explícita qué profesional es responsable en cada etapa del proceso, según el organigrama del centro.
Registros:	Indicar en qué registros se anotaran las actividades llevadas a cabo, especificando qué se registrara, como y las incidencias producidas.

Elaboración y vigencia:	Se hará constar la fecha de realización, profesionales que lo han elaborado, vigencia del protocolo, fecha prevista de valoración de su funcionamiento i firma que las personas que lo han elaborado.

Fecha de revisión y firma:	La revisión se llevará a cabo en la fecha prevista o antes si se cree conveniente. Será necesario que se haga constar qué profesionales lo han revisado tanto si hay modificaciones como si no ha habido (si es posible, las mismas personas que lo han elaborado), fecha y firma.

En las UF de los siguientes módulos veremos ejemplos de diferentes protocolos de actuación (higiene, medicación…)

2.2.- Transmisión al usuario de información sobre las actividades. Actividades opcionales, voluntarias y obligatorias.

Como ya se ha indicado en el apartado 1.5 de esta UF, debemos dar una información adecuada sobre dichas actividades: horario en que se realizan, lugar y personas que intervienen, etc. La información debe ser trasmitida con antelación suficiente a través de carteles, pero el profesional de atención sociosanitaria la complementará, informando personalmente. Las características de esta información ya se han citado en dicho apartado.

Las ACTIVIDADES OPCIONALES o VOLUNTARIAS son todas las relacionadas con el tiempo libre y de ocio, que deben ser elegidas de manera autónoma y voluntaria por el residente, dentro de sus capacidades de elección.



LAS ACTIVIDADES OBLIGATORIAS son todas aquéllas relacionadas con las ABVD (alimentación, higiene, vestido, etc.) y su mantenimiento, así como todas las actividades terapéuticas o educativas programadas e incluidas dentro del plan de intervención individual de cada usuario.



2.3.- Manejo de los materiales más comunes para la realización de actividades en instituciones sociales.

Materiales fungibles e inventariables.

El MATERIAL FUNGIBLE es aquel que va a ser consumido y no se guarda tras su uso. Por ejemplo, las gasas, las agujas de insulina, los pañales, las sondas de alimentación, los baberos desechables…

El MATERIAL INVENTARIABLE es aquel que perdura de un usuario a otro y puede ser guardado en un almacén tras su uso como puede ser el mobiliario, la lencería, el carro de curas, la vajilla…

Juegos de mesa.



Este tipo de juegos se utilizan con una triple finalidad: recreativa (ocupación del tiempo libre y de ocio), social (fomento de las relaciones sociales) y terapéutica (entrenamiento de habilidades y funciones cognitivas: cálculo, memoria, lenguaje, etc.).

Para lograr estos objetivos, es importante que los juegos que se empleen estén adaptados a los usuarios a los que están destinados. Es fundamental, como en todos los materiales que se manejen en la institución, que su diseño sea universal y que todos los residentes puedan utilizarlos, es decir, que sean accesibles a todos aquéllos que quieran hacer uso de ellos.

El Instituto Tecnológico del Juguete (AIJU) ha desarrollado diferentes estudios sobre la adaptación de los juegos y juguetes a personas mayores y a individuos con discapacidad. Estas son algunas de las adaptaciones y recomendaciones para el diseño de este tipo de juegos:

- Evitar materiales deslizantes que dificulten el agarre, utilizando otros de tipo no pulido que faciliten el reconocimiento táctil.
- Incluir avisadores de tiempo sonoros que permitan adaptar la velocidad de respuesta a las preferencias de los diferentes grupos de jugadores.
- Incorporar control de volumen en los juegos sonoros para facilitar la escucha de los mensajes emitidos por la estructura.
- Evitar el uso de idiomas o vocabulario no conocidos por los jugadores potenciales.
- Utilizar colores saturados que faciliten el reconocimiento y distinción de las gamas cromáticas utilizadas en los diferentes componentes.
- No incluir fichas planas y pequeñas que dificulten el agarre. Se recomienda utilizar fichas con forma de pivote, pues cogerlas resulta mucho más sencillo.
- Simplificar los textos de las instrucciones, los gráficos y tablas que las acompañan, garantizando una lectura fácil y comprensiva.
- Utilizar letras y números de tamaño y contraste adecuado.
- Garantizar espacios suficientes para una escritura cómoda en caso de incluir libretas para notas que deban usarse durante el juego.
- Evitar diseños que demanden una amplia movilidad articular.

En el caso de una persona, por ejemplo, con un déficit visual, siguiendo las indicaciones de AIJU, se debería incorporar al juego de mesa sonidos, relieves o texturas que sustituyan o acompañen al estímulo visual, así como dotar de relieve al tablero y colocar en las fichas algún sistema de sujeción (por ejemplo, velero) con el

fin de que no se desplacen involuntariamente. Así, se podría, en este caso, utilizar barajas gigantes (iguales que las normales, pero de un tamaño considerablemente superior) o tableros perforados (permiten colocar las fichas sin que éstas se muevan de manera involuntaria).

- Realización de inventarios y listados.

El inventario es el listado que contiene todos los bienes tangibles de la institución, ya sea en soporte informático o en papel. Entre las funciones del profesional sociosanitario está la de elaborar inventarios de todos los bienes necesarios para la asistencia que debe dispensar a la persona usuaria. También debe observar y comunicar al equipo interdisciplinar las incidencias en el orden y el estado de los materiales existentes (roturas, pérdidas, robos, caducidad…).

No hay un único método para realizar un inventario, pero una manera de hacerlo es:

1. Describir los productos a inventariar
2. Cuantificar la cantidad necesaria del material para un correcto funcionamiento del servicio indicando la unidad (por ejemplo 10 toallas o 5 botes de gel de 250 ml.). No duplicar la información
3. organizar el espacio físico a inventariar:
    a. Vaciar, contar y limpiar el almacén, armario o estantería a inventariar.
    b. Indicar qué colocamos donde
    c. Colocar ordenadamente, de modo lógico e igual todos los materiales a inventariar.
4. realizar un listado de los materiales inventariados.

Este listado debe recoger la descripción, la cuantificación y debe permitir anotar las modificaciones que se realizan de cada material.

Por ejemplo en la siguiente tabla se recoge el inventario de prendas y enseres personales del armario de un usuario

INVENTARIO DE PRENDAS Y ENSERES PERSONALES

Nombre del usuario:						N.° de ropa asignado:				**N.° de habitación:**
PRENDA	I.ª entrada	Fecha	Entrada	Salida	Saldo	Fecha	Entrada	Salida	Saldo	Especificar tejidos, colores, estampados, etc.
ABRIGO										
BATÍN										
BOTAS										
CALCETINES										
MUDA										
CAMISAS/ BLUSAS										
CAMISETAS										
CHAQUETA										
CINTURONES										
GAFAS										
GORRAS										
PANTALONES/ FALDAS										
PIJAMAS										
SUÉTER/JERSEY										
TRAJE										
ZAPATOS										
DENTADURA										
BASTÓN										

Además de realizar el inventario de materiales es preciso llevar un control de los movimientos de los mismos. Por ejemplo, para llevar un control del carro de la lencería se puede elaborar una hoja similar a esta para cada planta. En ellas cada día se anota la ropa sucia retirada de cada habitación, anotando en la columna de la izquierda los números de las habitaciones y en la horizontal de arriba, cada una de las clases de ropa que hay en la habitación y su estado:

habitación	SI	SE	C	F	M	TB	TL	SUCIO	ROTO	FALTA

SI: sábana bajera SE: sábana encimera C: colcha F: fundas almohada
M: manta TB: toalla baño TL: toalla lavabo

O este otro ejemplo ilustra como inventariar y registrar el carro de curas o el almacén de los medicamentos

MODELO DE CONTROL DE MATERIALES

ÁREA/DEPARTAMENTO: _____ MES:

MATERIAL	Código de Ubicación	Fecha entrada	Fecha salida	Cantidad	Responsable	Observaciones

Los listados que tendrá que manejar el personal del centro serán los siguientes:

1. Listado de usuarios con cambios posturales pautados
2. Listado de baños y duchas programados
3. Listado de siestas pautadas
4. Listado de paseos programados
5. Listado de usuarios incluidos en programas de terapia ocupacional, fisioterapia y psicología
6. Listado de usuarios para actividades extraordinarias
7. Listado de productos de apoyo
8. Listado de dietas y control de dietas diarias
9. Los que en la institución se consideren oportunos

Estos serán diseñados por consenso por el equipo interdisciplinar.

2.4.- Revisión del estado de las ayudas técnicas.

La Norma ISO 9999:2007. Productos de apoyo para personas con discapacidad. Clasificación y terminología, publicada por AENOR en 2007 sustituye el antiguo término de «ayudas técnicas» por el de «productos de apoyo».

La norma define producto de apoyo como: "Cualquier producto (incluyendo dispositivos, equipo, instrumentos, tecnología y software) fabricado especialmente o disponible en el mercado, para prevenir, compensar, controlar, mitigar o neutralizar deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación."

Ejemplos de productos de apoyo: sillas de ruedas, dispositivos Braille, síntesis de voz, ayudas de baño…

Para la creación de productos de apoyo se usan conceptos y conocimientos extraídos de la ergonomía[2] y otras disciplinas, con el objetivo de que el producto resultante sea adecuado a las características del usuario y le permita compensar su limitación en el acceso a entornos o productos.

En la página http://www.catalogo-ceapat.org/UNE-EN_ISO_9999-2007.pdf encontraras ampliada esta información

Aunque es tarea del terapeuta ocupacional conocer los diferentes tipos de productos de apoyo y establecer cuáles son los indicados o recomendados para esos usuarios, el profesional de atención sociosanitaria debe conocerlos y saber manejarlos, puesto que es función suya la revisión del estado y la limpieza de los productos de apoyo utilizados por los ingresados.

Siguiendo las pautas marcadas por los protocolos de limpieza y de los fabricantes de productos de apoyo existentes en el centro, el personal de atención sociosanitaria revisará el estado de los mismos.

Para ello realizará las siguientes acciones:

- Comprobar que el producto de apoyo se encuentra en perfectas condiciones para su uso (tornillos ajustados, pilas o baterías cargadas, etc.).
- Revisar que el producto de apoyo esté correctamente marcado con los datos del usuario o del centro para evitar pérdidas o extravíos en posibles salidas al exterior.
- Realizar la limpieza periódica marcada en el protocolo y reflejará dicha limpieza en los registros habilitados para ello

2.5.- Distribución y adecuación de espacios y mobiliario.

El Decreto 41/1998, de 10 de marzo, sobre los servicios sociales residenciales para la tercera edad, publicado en el BOPV nº 1998066 el 7 de abril de 1998 indica las características específicas que una institución debe guardar en la CCAA País Vasco.

2 es la disciplina científica relacionada con la comprensión de las interacciones entre los seres humanos y los elementos de un sistema, y la profesión que aplica teoría, principios, datos y métodos de diseño para optimizar el bienestar humano y todo el desempeño del sistema

Según dicho boletín con carácter general, todos los *SERVICIOS SOCIALES RESIDENCIALES* para la tercera edad, tanto los de titularidad pública como privada, deberán cumplir con los requisitos que a continuación detallamos.

Se emplazarán en zona céntrica del municipio o, en su defecto, en lugar debidamente comunicado con el centro mediante transporte público. En su caso, se facilitará por parte del servicio social residencial a las personas usuarias, en determinados días y horas, de otro medio alternativo de transporte al centro del municipio. Además, la zona de ubicación del servicio no será especialmente ruidosa ni peligrosa para la integridad física de las personas usuarias, reunirá la debida salubridad y contará con alrededores bien iluminados.

Contará con jardines o espacios exteriores amplios donde poder pasear o, al menos, fácil acceso a plazas o jardines públicos.



Disponibilidad de iluminación y de ventilación naturales y directas, sobre todo en las zonas más utilizadas por las personas usuarias: habitaciones y salas de estar. Además, en relación con dichos aspectos, se establecen las especificaciones siguientes:

- Todas las habitaciones deberán tener una ventana exterior de un mínimo de 1/10 de su superficie y ventilación con un mínimo de 1/20 de su superficie.
- Las salas y dependencias cerradas que puedan ser utilizadas habitualmente por las personas usuarias o el personal, deberán disponer de ventilación y renovación del aire.

Los elementos de calefacción, contarán con medidas de seguridad adecuadas, que deberán funcionar siempre que la temperatura ambiente lo requiera.

Se dispondrá de al menos un teléfono por cada planta, que permita la conexión con el exterior.

Se observará un estricto respeto a la privacidad de las personas usuarias. En este sentido, se deberán cumplir, entre otros, los puntos siguientes:

- Se permitirá tener cerrada la puerta de la habitación o, en su caso, del apartamento.
- El personal llamará a la puerta y esperará a que se le invite a entrar.
- En ningún caso podrá observarse el interior estando la puerta cerrada.
- Los armarios y cajones se podrán cerrar con llave.

Cada habitación, y su aseo en su caso, dispondrá de:

- Un diferencial de alta sensibilidad y magnetotérmicos.
- Timbres de llamada en habitación y su aseo, con aviso en un puesto de control, que permita identificar su procedencia.
- Además, al pulsar el timbre de alarma se encenderá un piloto sobre la puerta de la habitación, que se apagará con un pulsador de rearme.
- Luz de sueño, a base de una lámpara de luz difusa de pequeña potencia, cuyo mecanismo ha de quedar empotrado en el paramento a 30 cm. del suelo y accionado por interruptor en su vertical.



Los SERVICIOS HIGIÉNICOS mínimos serán:

- En zona de habitaciones se exigirá un inodoro, un lavabo sin pedestal y una ducha por cada cuatro personas usuarias.
- En zonas comunes se exigirá un lavabo sin pedestal y un inodoro por cada 15 personas usuarias. Se contará con barras de apoyo
- Las duchas no deberán presentar ninguna barrera arquitectónica en el suelo, dispondrán de grifería tipo teléfono y de un sumidero sifónico de gran absorción en el suelo de tal forma que, mediante el uso de sillas «ad hoc», se facilite la higiene de los/as residentes que se vean obligados a utilizar silla de ruedas.
- Todas las residencias de más de 50 plazas deberán contar, al menos, con un cuarto de baño geriátrico asistido. La superficie del cuarto de baño medirá un mínimo de 15 $m^{.2}$ y contará con bañera adaptada, un inodoro y un lavabo sin pedestal, permitiendo la maniobra de una grúa geriátrica.
- Los cuartos de aseo de las habitaciones y las cabinas de aseo ubicadas en zonas comunes dispondrán de condena con botón de desbloqueo exterior

- Tendrán una superficie mínima que permita realizar un círculo de 150 cm de diámetro
- Los grifos se accionarán mediante sistemas de presión o palanca.
- El inodoro estará colocado a 45 o 50 cm de altura para facilitar la transferencia desde silla de ruedas, contando con barras de apoyo, siendo la del lado de acceso abatible.
- Los cuartos de baño dispondrán de un sistema de alarma conectado a un puesto permanente de control.
- Se contará con al menos un baño apto para camillas

Las ÁREAS COMUNES presentarán



- Se considerarán espacios comunes los comedores, salas de estar, salas de actividades y ocupacionales. Deberán tener una superficie mínima en su conjunto de 4,5 $m.^2$ útiles por cada residente.
- Las Residencias deberán cumplir los requisitos exigidos en la legislación vigente, en especial la Reglamentación técnica sanitaria recogida en el Real Decreto 2817/1983, de 13 de octubre, sobre comedores colectivos.
- Las mesas serán de tales características que permitan su uso por personas sentadas en sillas de ruedas (70 cm de alto)
- Es aconsejable la utilización de varios espacios de dimensiones reducidas con preferencia a una única sala de grandes dimensiones.

- Mediante el diseño adecuado, se creará distintos ambientes que eviten la sensación de masificación.
- Las zonas de comedor y estar deberán ubicarse, preferentemente, en la planta baja, y disponer de mobiliario diferenciado para cada zona.

- Se contará, como mínimo, con mueble biblioteca.

Las HABITACIONES deberán cumplir los siguientes requisitos:

- Ocupar un lugar específico, no pudiendo, en consecuencia, ser paso obligado a otra dependencia.
- Serán individuales o dobles. El porcentaje de las primeras respecto del total de plazas no será inferior al 25%. Estos porcentajes son mínimos; no

obstante, dada la importancia que tiene la intimidad personal para la convivencia, se recomienda como tipo ideal la habitación individual.

- La superficie mínima de la habitación doble será de 14 m.^{2}, excluido el cuarto de aseo.
- La superficie mínima de la habitación 10 m.^{2}, excluido el cuarto de aseo.
- Todas las habitaciones estarán diseñadas de manera que permitan la circulación en silla de ruedas y sin maniobras complicadas.
- Los pavimentos serán de material fácil de limpiar y no deslizante.
- La iluminación permitirá la lectura y el trabajo.
- Todo residente dispondrá como mínimo en su habitación del siguiente equipamiento:
  1. Una cama con anchura mínima de 90 cm (si el estado físico de el/la residente lo requiere, dispondrá de una cama articulada.) y con una altura mínima de 45 cm para que la transferencia sea más fácil, siendo articuladas para personas con reducida movilidad o que utilicen silla de ruedas.
  2. Un armario con llave y una capacidad mínima de 1 m.^{3}.
  3. Una mesilla de noche con cajón, esquinas redondeadas o guardavivos protectores.
  4. Una silla con apoyabrazos.
  5. Una mesa de uso individual o compartido que permita su utilización por personas sentadas en silla de ruedas.
  6. La distancia lateral entre una cama y un paramento no será menor de 50 cm, y el espacio del lado opuesto, así como a los pies de la cama, deberán medir más de 90 cm. Esta última distancia existirá como mínimo entre camas.
  7. En el caso concreto y exclusivo de aquellas personas residentes con trastornos psíquicos que puedan alterar la normal convivencia del centro y estén necesitadas de cuidados especiales, el diseño de la habitación destinada a las mismas podrá experimentar alguna desviación con respecto al definido en el apartado A, tendente a mejorar la seguridad y la atención de estas personas.



Tanto si los servicios de atención geriátrica se prestan con personal propio como si son concertados, todas las residencias de más de 25 plazas deberán disponer, como mínimo, de los siguientes espacios:

- Sala de consulta dotada de espacio suficiente, que permita la consulta verbal, así como el reconocimiento y exploración de las personas residentes, con un lavabo con agua caliente y fría.
- Cuarto de curas y botiquín, que el caso de las residencias de hasta 50 plazas, podrá constituir espacio conjunto con la sala de consulta. E cuarto de curas dispondrá de lavabo de agua caliente y fría.
- Sala de fisioterapia y rehabilitación, destinada a la realización de ejercicios físicos de mantenimiento y recuperación, con una superficie mínima de 2n/5 $m.^2$, donde n es el número de personas residentes, no pudiendo ser en ningún caso inferior a 15 $m.^2$. Se situará próxima a los servicios higiénicos.

En todas las residencias de más de 70 plazas existirá una sala dedicada exclusivamente a MORTUORIO, con las siguientes características:

- Superficie mínima de 12 $m.^2$.
- Ventilación directa y temperatura adecuada.
- Comunicación interior con el resto de la residencia y acceso exterior próximo y adecuado a su uso.

En cuanto al MOBILIARIO de una institución para personas dependientes, éste deberá estar adaptado a las necesidades de las personas usuarias y deberá poseer las características que garanticen su seguridad para realizar una vida lo más normalizada posible, reduciendo los factores de riesgo o el aislamiento y aportando bienestar, con apariencia similar a la de una vivienda corriente. Es el factor ambiental más fácil de modificar. En general se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

- En las zonas comunes se tratará de dar una apariencia de ambiente hogareño. Se pueden colocar, por ejemplo, cuadros y elementos decorativos que ayuden a dar esa apariencia.
- El mobiliario será fijo y estable, de líneas sencillas, de bordes redondeados, superficies mates y color contrastado.
- El mobiliario se dispondrá de manera que favorezca la movilidad de los usuarios. A las mesas se podrán aproximar frontalmente personas en sillas de ruedas.
- Se evitarán accesorios y adornos que puedan ser frágiles o peligrosos.
- Se tendrán en cuenta las características higiénicas de los materiales de acabado de las dependencias (pinturas lavables) y de los muebles (tapicerías, acolchados lavables e ignífugos). Es aconsejable que todos los sillones y sillas estén provistos de tapicería o fundas lavables, y que estén confeccionados con materiales resistentes al fuego.

LAS VIVIENDAS COMUNITARIAS reguladas mediante el citado Decreto, deberán cumplir los requisitos que a continuación se detallan.

Constituirán espacios físicos accesibles, tanto externa como internamente, incluso para personas con cierto grado de discapacidad.

Deberán disponer de ascensor u otro medio elevador de personas, en el supuesto de que la vivienda esté parcial o totalmente ubicada en planta diferente a la baja.

La vivienda comunitaria deberá tener una superficie útil mínima de 20 $m.^2$/persona, destinando 4,5 $m.^2$/persona para sala de estar-comedor.

Las habitaciones de la vivienda podrán ser dobles o individuales. La proporción de habitaciones individuales representará, como mínimo, el 25% del total de las plazas.

La vivienda deberá contar con 1 servicio higiénico por cada 4 personas. La dotación del mismo incluirá: inodoro, lavabo y ducha o bañera.

Cada habitación deberá tener timbre de llamada conectado a un puesto de control.



La vivienda dispondrá de teléfono comunicado con el exterior.

Como norma general, contarán con un ratio de 0,25 para plazas de válidos y 0,45 para plazas asistidas. En el caso de contar con plazas de válidos y de asistidos, la Administración competente, teniendo en cuenta la proporción "residentes válidos/residentes asistidos" determinará el número mínimo de personal exigible.

Las viviendas comunitarias deberán contar con señalización, iluminación de emergencia y estar dotadas con extintores portátiles como instalaciones mínimas contra incendios:

LOS APARTAMENTOS TUTELADOS, regulados mediante el citado Decreto, contarán con una persona física que tendrá asumida la responsabilidad de servir de referencia a las personas usuarias.

Constituirán espacios físicos accesibles tanto externa como internamente, incluso para personas con cierto grado de discapacidad. Deberán disponer de ascensor u otro medio elevador de personas, en el supuesto de que la vivienda esté parcial o totalmente ubicada en planta distinta a la baja.

La superficie mínima de los apartamentos será de 25 m^2 si es un apartamento individual y de 35 m^2 si es doble.

El equipamiento mínimo de cada apartamento será: cocina, sala de estar-comedor, habitación y cuarto de aseo. Únicamente este último deberá ubicarse necesariamente en espacio diferenciado.

Cada apartamento deberá tener un sistema de intercomunicación adecuado para situaciones de emergencia.

El conjunto de apartamentos dispondrá de teléfono comunicado con el exterior.

Contarán con servicios comunes de uso facultativo y un espacio polivalente.

Los espacios de acceso a los apartamentos deberán contar con las mismas instalaciones técnicas que las viviendas



Además hay que cumplir con toda la normativa vigente en materia de accesibilidad universal en TODO tipo de instituciones

2.6.- Comprobación de las condiciones de seguridad y accesibilidad.

Además de las especificaciones citadas en el apartado anterior para áreas comunes, servicios higiénicos y habitaciones hay que tener en cuenta lo siguiente:

- Los PASILLOS tendrán un ancho mínimo de 90 cm, se recomienda 120 cm que es la anchura que permite el cruce de dos sillas de ruedas o camillas. Contará con pasamanos en todas las zonas de tránsito de usuarios a una altura de 95cm.



- Las RAMPAS hay que hacerlas con pavimento antideslizante. La pendiente de la rampa vendrá determinada por la longitud de la misma, siendo de un máximo del 8 %, salvo en tramos de longitud inferior a 1 000 cm (hasta 10 % de pendiente) o en tramos de longitud inferior a 300 cm (hasta 12 % de pendiente).
- El ancho de las PUERTAS será de 80 cm de paso como mínimo. Las de la entrada alcanzarán los 1,50cm y no son admisibles puertas giratorias. Los tiradores serán de presión o de palanca, no se admiten los pomos y estarán situados a una altura no superior a 100 cm. Las puertas de los aseos abrirán hacia fuera o serán correderas. Los sistemas de cierre interior tendrán un mecanismo de apertura desde el exterior para casos de emergencia.



- El ASCENSOR será obligatorio si hay más de una planta, con dimensiones mínimas de 120 cm de fondo por 90 cm de ancho. Las puertas serán automáticas con un ancho libre mínimo de 80 cm y se recomienda que tengan sistemas de retardo de la apertura.

Otro factor importante del entorno son los elementos de señalización. Las señales y los carteles informativos proporcionan información sobre el interior del edificio, la

ubicación de determinados lugares, la existencia de peligros, las normas de seguridad, las celebraciones de actividades, etc. Su objetivo es facilitar al residente la orientación dentro del edificio para poder desenvolverse dentro del mismo de la manera más autónoma posible. Para el correcto diseño y ubicación de las señales y carteles han de tenerse en cuenta además de las características de los usuarios de la institución los siguientes elementos:

- Ubicación de los carteles y señales: en lugares de fácil localización y a una altura adecuada para que todos los ingresados puedan verlos. Entre 145 y 175 cm, centrado a 160 cm. La información debe poder ser leída a corta distancia. Los planos del edificio se situarán en la recepción, cerca de la puerta de entrada.
- Modalidad del mensaje: la información relevante se presentará de forma visual y acústica, y en los casos necesarios de forma táctil (sistema braille).
- Información: será clara y comprensible (frases breves y simples), y se utilizarán para los caracteres colores que contrasten con el de fondo (por ejemplo, caracteres blancos en fondo azul oscuro).
- Elementos de señalización de los materiales: es preciso, dadas las características de algunos usuarios, señalizar la ubicación y descripción de algunos de los materiales que se utilizarán en el centro. Con ello, lograremos no sólo tenerlos ordenados, sino también que los dependientes puedan identificarlos con facilidad.

Existe una amplia gama de tipos de señalización en función de los residentes y debemos buscar la que sea más adecuada para ellos. Algunos tipos serán: rótulos con el nombre de los objetos que contiene una caja, rótulos con dibujos de los objetos que contiene una caja (pictogramas), cajas de diferentes colores para almacenar diferentes objetos, etc. Es fundamental adaptar la señalización a cada usuario o grupo de usuarios

Para conseguir una mayor AUTONOMÍA FÍSICA de los usuarios los suelos no serán deslizantes, se colocarán pasamanos a las alturas adecuadas, se dotará de productos de apoyo a aseos y baños (barras de apoyo), etc.

Los espacios atenúan las discapacidades sensoriales. Por ello, se distribuirá el mobiliario para evitar efectos de eco o dificultades de comunicación, los sistemas de megafonía y alarma tendrán una potencia adecuada a las necesidades de los usuarios, y la iluminación será adecuada para facilitar una visión correcta.

Para lograr una mayor SEGURIDAD PSÍQUICA en los ingresados los espacios estarán bien definidos y serán identificables para evitar la desorientación espacial. De este modo, se utilizarán materiales, texturas y colores diferenciados. Además, se emplearán señales de indicación, símbolos representativos del uso de las estancias, fotografías de los dependientes en las puertas de las habitaciones, etc., que permitan una fácil identificación. Se evitará efectuar cambios bruscos en el ambiente para evitar la desorientación y se colocarán relojes y calendarios de gran tamaño para favorecer la orientación temporal.

Asimismo, con el fin de conseguir una mayor seguridad psíquica se mantendrá el contacto con el exterior, haciendo uso de las zonas de jardines o terrazas, y se evitará los enrejados en ventanas, utilizando otras medidas de seguridad como cierres desmontables o acristalamientos de seguridad.

Los espacios y su empleo permiten la privacidad e intimidad, pero también favorecen las relaciones sociales y la vida en comunidad. Se habilitarán salones grandes, aunque también otros pequeños para grupos reducidos. Cuando se ubique a los usuarios en las zonas comunes, se les colocará de manera que se facilite el contacto visual y verbal, por ejemplo en círculo.

Para conseguir una mayor SEGURIDAD FÍSICA en los residentes, se asegurará y comprobará que no existe riesgo de caídas por la distribución del mobiliario. Se utilizarán organizaciones espaciales diáfanas y libres de elementos decorativos que supongan un obstáculo para el desplazamiento, se evitará la colocación de alfombras y cables que crucen las estancias, así como elementos o personas en sillas de ruedas en las zonas de paso del centro.

Se usarán productos de limpieza antideslizantes. La iluminación será suficiente, y se evitarán las zonas oscuras, así como los contrastes y las sombras. Se taparán los elementos de calefacción con cubrerradiadores para evitar quemaduras.

Con el fin de mantener unas condiciones de seguridad óptimas para los residentes, también se controlará la medicación; así, se comprobará que los usuarios toman correctamente la medicación, no dejando nunca ésta sobre las mesas o al alcance de ningún ingresado.

Además, se controlará el material, sobre todo el de limpieza, prestando especial cuidado a los productos líquidos para evitar ingestas accidentales. El material para la alimentación también será controlado, no se dejarán cuchillos al alcance de los residentes y se utilizará vajilla de materiales irrompibles (por ejemplo, el policarbonato).

Asimismo, la supervisión en sala de los usuarios es importante. Los residentes que permanezcan en estas salas estarán siempre vigilados por el profesional de atención sociosanitaria. Además, el profesional de atención sociosanitaria acompañará a los usuarios que requieran supervisión a las diferentes salas donde tengan que realizar alguna actividad. Se vigilará especialmente a los ingresados con riesgo de fuga o deambulación errante. Es importante también la supervisión nocturna, en la que se realizarán rondas de vigilancia para garantizar que ningún dependiente sale de su habitación o está en situación de riesgo dentro de la misma.

Las adaptaciones del entorno deben ser realizadas para favorecer la accesibilidad y seguridad de los usuarios, pero también tienen que ser entornos seguros para los profesionales que trabajan en la institución y la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, especifica que todos los trabajadores tendrán derecho a una protección eficaz en las materias de seguridad y salud en su trabajo.

Además, los trabajadores tendrán que ser formados e informados sobre los riesgos de su puesto laboral y medidas de prevención para evitarlos.

Según la obra Prevención de riesgos en residencias de la tercera edad (1995), los principales RIESGOS relacionados con el entorno PARA EL PUESTO DE TRABAJO del profesional de atención sociosanitaria en una institución de atención a personas mayores y, por similitud física y espacial, en cualquier centro de atención a personas dependientes, son los siguientes:

a) Riesgo de caídas: pueden ser caídas al mismo nivel (por suelos resbaladizos o presencia de obstáculos en las zonas de paseo), a distinto nivel (desde escaleras fijas o de servicio) o caídas de objetos en manipulación sobre las zonas del cuerpo del trabajador.
b) Riesgo de choque contra objetos inmóviles: por ejemplo contra el mobiliario del centro (cajones abiertos, mesitas, etc.).
c) Riesgo de sobreesfuerzos musculares: éste puede producirse cuando el profesional sociosanitario lleva a cabo la movilización de los usuarios.
d) Riesgo de cortes o pinchazos: este tipo de riesgo puede ocasionarse con útiles y material sanitario o de preparación de la comida o limpieza (cuchillos, tijeras, agujas, etc.).
e) Riesgo de electrocución: éste se puede producir por el manejo de material de trabajo como, por ejemplo, grúas eléctricas, maquinillas de afeitar, etc.
f) Riesgos biológicos por infecciones transmitidas por sangre o fluidos corporales: hay que prestar especial atención al riesgo de infección a causa de enfermedades que los usuarios pueden transmitir al personal durante su higiene.
g) Riesgo de incendios: este tipo de riesgo puede ocasionarse por contactos eléctricos, cigarrillos mal apagados, etc.
h) Riesgos de carácter psicosocial como son el riesgo de estrés, de agresiones por parte de los usuarios, los derivados del trabajo a turnos o en turnos inadecuados, etc.

El personal de atención sociosanitaria debe conocer estos riesgos, siendo informado por la empresa, y además tiene que saber cómo prevenirlos. Las medidas preventivas básicas serán las siguientes:

- Se utilizará calzado adecuado, evitando los zuecos. Se respetarán las vías de circulación y se mantendrán las zonas de paso en perfecto estado de uso y sin mobiliario que obstaculice el paso y las salidas.
- Se mantendrán los cajones cerrados y se organizará el mobiliario de manera que permita un fácil acceso a los lugares, sin riesgo a golpearse.
- Se harán descansos periódicos.
- Se manipularán las cargas de forma adecuada, realizando la movilización entre varias personas cuando sea necesario, y se transportarán las cargas con ayuda de medios auxiliares (grúas de movilización).

- Se mantendrá el lugar de trabajo limpio y ordenado, se guardarán los útiles después de uso y se desecharán las agujas depositándolas en los contenedores siempre después de su utilización.
- Nunca se usarán los equipos con las manos húmedas o mojadas, se evitará limpiar con líquidos cualquier equipo conectado a la corriente y se evitarán salpicaduras. Se desconectarán los aparatos eléctricos si no van a usarse durante periodos largos de tiempo. Se comunicarán las averías de los equipos eléctricos al personal responsable y se desenchufarán.
- Se emplearán de manera rutinaria las medidas de protección adecuadas para evitar el contacto de piel y mucosas con sangre o fluidos corporales; por ejemplo guantes, que serán desechados después de cada contacto. Se usarán mascarillas cuando pueda existir riesgo de contagio. El personal se acogerá a campañas de inmunización, como en el caso de vacunación frente a la gripe.
- Se evitará almacenar materiales combustibles cerca de fuentes de calor, se mantendrá el lugar de trabajo ordenado y limpio, se respetarán las prohibiciones de fumar y al entrar en las áreas donde esté prohibido se apagarán las colillas en ceniceros, no en cualquier parte. Se vigilará a los usuarios fumadores para evitar que lo hagan en zonas prohibidas. Se conocerá la señalización, vías de salida y la localización de pulsadores de alarma y extintores cercanos. No se obstaculizarán los recorridos ni las salidas de emergencia.
- Además, existirá en el centro un plan de emergencias sobre el que el personal deberá estar informado y debidamente formado, que contendrá un plan de actuación ante emergencias, un plan de actuación ante incendios y un plan de evacuación.

2.7.- Registro de incidencias.

Periódicamente el personal de atención sociosanitaria llevará a cabo una inspección de las instalaciones siguiendo las pautas marcadas por su supervisora. En dicha inspección anotará el estado de las estancias y del mobiliario.

Para el control de dichas incidencias, se pondrá a su disposición una serie de registros para anotar aquéllas que detecte en su labor cotidiana y en las inspecciones periódicas que le marque la supervisora.

Así, por ejemplo, puede existir un registro de revisión de habitaciones similar a este:

Habitación Paciente	Fecha	

Elemento inspeccionado	Resultado	Observaciones
Estado de armario		
Estado de mesillas		
Mobiliario		
Iluminación		
Cortinas		
Lencería		
Cristales		
Lavabo		
Inodoro		
Grifería		
Espejo		
Suelo		
Papel higiénico		
Toallas		
Revisado por		
Firmado		

Si hubiera alguna incidencia se deberá registrar en un parte de incidencias para que sea subsanada. Un parte correspondiente a la de revisión de habitaciones puede ser algo similar a este:

Habitación	Fecha	
Parte n,°		
Instalación/equipo:	Detectado por:	
Descripción de la avería o el desperfecto:		
Empresa de mantenimiento avisada:	Fecha y hora del aviso:	
Fecha de reparación:	Revisado por: (fecha y firma)	

Dos cuestiones respecto al procedimiento a seguir con los registros de incidencias:

1. Este protocolo de control tiene el propósito de recoger y trasladar a otros profesionales información básica sobre la situación y evolución diaria de una persona usuaria que se considera debería ser conocida; puede ser informático.
2. Ha de adaptarse al número de usuarios y de profesionales de cada centro y establecerá unas normas o criterios que permitan el uso de términos comunes para una redacción puntual, suficientemente breve y clara de lo ocurrido, así como del nombre y habitación del usuario.

3. Participación en la organización funcional en una institución sociosanitaria

En este apartado pretendemos mostrar cómo la organización de las actividades facilita la respuesta a las necesidades individuales de los usuarios y permite optimizar los recursos humanos y materiales disponibles, adaptándose a los protocolos de actuación establecidos.

Para ello, es necesario que el profesional en atención sociosanitaria conozca la metodología de trabajo adecuada: distribución de tareas, transmisión de la información y uso de indicadores de calidad.

3.1.- Distribución de tareas: Horarios, turnos y grupos de trabajo.

Mediante la distribución de las tareas se marca qué actuaciones hay que llevar a cabo con cada residente, en qué momento y quién debe realizarlas, garantizando de

esta manera una atención de calidad, que cubra todas las necesidades de los usuarios.

Esta distribución de responsabilidades laborales se realizará teniendo en cuenta los diferentes horarios que tendrá cada grupo profesional, así como los turnos de trabajo en que se dividirá la atención profesional cada día.

Para llevar a cabo dicha distribución, se elaborará una serie de grupos de trabajo que especificarán las tareas que se deben realizar y los usuarios que han de atender.

A continuación, analizaremos la distribución de horarios, turnos y grupos de trabajo que tendrán que intervenir para llevar a cabo una correcta atención al dependiente en el centro sociosanitario.

Los horarios son:



1. Horario de mañana**:** desde las 8 a las 13 h, aproximadamente, se concentrarán actividades asistenciales, terapéuticas y educativas. Así, se realizarán las ABVD relacionadas con la higiene y el aseo; se llevarán a cabo actuaciones de fisioterapia, terapia ocupacional, actividades educativas y formativas; y la mayor parte de tareas de carácter sanitario como, por ejemplo, consultas médicas, curas, etc. Ésta es la franja horaria de mayor actividad programada.
2. Horario de tarde: la actividad programada comenzará normalmente alrededor de las 17 h, tras la merienda. En este horario suelen realizarse actividades de carácter lúdico, aunque también pueden llevarse a cabo actuaciones terapéuticas (terapia ocupacional, fisioterapia, etc.). Son horas en las que los usuarios suelen recibir más visitas de familiares y amigos.
3. Horario de noche**:** son horas dedicadas al descanso de los dependientes. La función principal de los profesionales en este turno será de vigilancia y supervisión.

En este sentido lo primero a realizar es una relación de tareas y los horarios en las que estas deben de ser realizadas. Por ejemplo:

HORARIOS	ACTIVIDADES	
8:00-9:45 h.	- Fisioterapia individual. - AVD: Promover, supervisar y ayudar en transferencias, baño, continencia, arreglo y vestido. - Cambio y revisión de pañales. - Traslado al comedor. - Tratamientos específicos, medicación de mañana, curas especiales, etc.	
9:45-10:30 h.	- Desayuno.	- Supervisión AVD
10:30-11:00 h.	- Traslado a zonas de actividades. Continencia	
11:00-12:30 h.	- (11:00/11:30) Tabla de gimnasia activa y pasiva para las personas usuarias. - (11:30/12:30) Estimulación cognitiva. - (11:30/11:45) Orientación a la realidad. - (11:45/12:30) Terapia ocupacional cognitiva y funcional. Psicomotricidad. - (11:30/12:30) Fisioterapia individual.	
12:30-13:00h.	- Revisión y cambio de pañal. - Lavado de manos.	- Traslados.
13:00-14:30h.	- Comida. - Administración de medicación.	- Supervisión AVD.
14:30-15:30h.	- Traslado, reposo y supervisión.	
15:30-16:00h.	- Reactivación. - Continencia, revisión de pañales.	- Traslado a zona de actividades.
16:00-17:00h.	- Paseos. - Animación socio-cultural. - Tertulias.	- Consejo de Centro. - Traslados al comedor.
17:00-18:00h.	- Merienda. - Administración de medicación.	- Supervisión AVD.
18:00-19:00h.	- Debates, tertulias, lectura, temas de interés,... - Animación y atención psicosocial. - Puertas abiertas, actividades culturales y celebraciones especiales. - Consejo de usuarios del centro. - Voluntariado. - Actividades recreativas y lúdicas.	- Ergoterapia individual. - Relajación. - Marcha y equilibrio con/sin instrumentos de apoyo a la marcha. - Ludoterapia de grupo. - Taller de recuerdos, canciones y juegos.
19:15-20:00h.	- Promoción de continencia, revisión y cambio pañal.	- Traslados.
20:00-21:00h.	- Cena. - Administración de medicación.	- Supervisión AVD.
21:00-22:00h.	- Traslado a habitaciones.	- Acostar.
22:00-8:00h.	- Supervisión, cambios posturales y promoción del sueño. - Revisión de pañales y cambios posturales a las 24:00h., 3:00h. y 6:00 h. como mínimo.	

Una vez decidida esta parte el siguiente paso es el de diseñar los grupos de trabajo que a su vez estarán formados por equipos. En la institución de atención a personas dependientes, los diferentes profesionales pueden trabajar de dos formas con los usuarios: de manera individual o por grupos de trabajo. Profesionales como médicos, psicólogos, fisioterapeutas o terapeutas ocupacionales pueden desarrollar actuaciones individuales con algunos residentes que precisen de una atención o un tratamiento personalizado. Estos mismos profesionales pueden llevar a cabo intervenciones con grupos de trabajo, desarrollando actividades con dependientes que reúnen una serie de características comunes como pueden ser grados de deterioro cognitivo o tipos de patología. Así, el terapeuta puede desarrollar una actividad de estimulación cognitiva con un grupo de trabajo de usuarios con alzhéimer en fase inicial o el fisioterapeuta hacer gimnasia con un grupo de trabajo de ingresados con parálisis cerebral.

El profesional de atención directa también trabaja con grupos de trabajo diferenciados. Para organizar el trabajo de auxiliares de enfermería, gerocultores y profesionales de la atención sociosanitaria de una manera eficiente, la supervisora asignará las tareas que se deben realizar por grupos de trabajo. Así, cada miembro del personal de atención directa tendrá a su cargo un grupo determinado mayor o menor, según el grado de asistencia de los mismos.

Un grupo de trabajo es un conjunto de usuarios y de tareas que deben ser realizadas por el profesional. Los usuarios suelen agruparse por características y necesidades similares

Según las necesidades detectadas en la distribución de horarios y actividades se diseñan los grupos y equipos de trabajo, asignando a cada las tareas a realizar.

Los turnos de trabajo son el horario laboral de cada profesional, lógicamente se adecuarán más o menos a los horarios de actividades y a los grupos de trabajo. Los turnos prácticamente coinciden con los horarios de actividades y por ejemplo serán algo similar a esto:

- Turno de mañana: normalmente de 7 (de 8 a 15 h) u 8 horas (de 7 a 15 h).
- Turno de tarde: también de 7 (de 15 a 22 h) u 8 horas (de 15 a 23 h).
- Turno de noche: generalmente de 8 (de 23 a 7 h) o 10 horas (de 22 a 8 h)

Los turnos se recogen y publican en un cuadrante para uno o dos meses. Por ejemplo:

Cuadrante mensual de junio

Nombre	V 1	S 2	D 3	L 4	M 5	X 6	J 7	V 8	S 9	D 10	L 11	M 12	X 13	J 14	V 15	S 16	D 17	L 18	M 19	X 20	J 21	V 22	S 23	D 24	L 25	M 26	X 27	J 28	V 29	S 30
[redacted]	A	C	C	B	B	B	B	A	A	A	A	C	C	B	B	B	B	A	A	A	A	C	C	B	B	B	B	A	A	A
[redacted]	A	A	C	C	B	B	B	B	A	A	A	A	C	C	B	B	B	B	A	A	A	A	C	C	B	B	B	B	A	A
[redacted]	A	A	A	C	C	B	B	B	B	A	A	A	A	C	C	B	B	B	B	A	A	A	A	C	C	B	B	B	B	A
[redacted]	A	A	A	A	A	C	C	B	B	B	B	A	A	A	A	C	C	B	B	B	B	A	A	A	A	C	C	B	B	B
[redacted]	C	B	B	B	B	A	A	A	A	C	C	B	B	B	B	A	A	A	A	C	C	B	B	B	B	A	A	A	A	C
[redacted]	C	B	B	B	B	A	A	A	A	C	C	B	B	B	B	A	A	A	A	C	C	B	B	B	B	A	A	A	A	C
[redacted]	C	B	B	B	B	A	A	A	A	C	C	B	B	B	B	A	A	A	A	C	C	B	B	B	B	A	A	A	A	C
[redacted]	A	A	C	C	B	B	B	B	A	A	A	A	C	C	B	B	B	B	A	A	A	A	C	C						
[redacted]	C	B	B	B	B	A	A	A	A	C	C	B	B	B	B	A	A	A	A	C	C	B	B	B	B	A	A	A	A	C
[redacted]	C	C	B	B	B	B	A	A	A	A	C	C	B	B	B	B	A	A	A	A	C	C	B	B	B	B	A	A	A	A

A = turno de mañana B = turno de tarde C = turno de noche

Para establecer el ratio personal/residentes, se considerará lo dictaminado en el DECRETO 41/1998, de 10 de marzo, sobre los servicios sociales residenciales para la tercera edad. Publicado en el BOPV n.º 66 del martes 7 de abril de 1998.

3.2.- Transmisión de la información. Utilización de lenguajes adecuados a las necesidades de las personas usuarias dependientes.

Para desarrollar una comunicación efectiva con las personas usuarias en centros de atención sociosanitaria se establecen una serie de recomendaciones para superar las barreras comunicativas específicas de estas personas.

Una exposición detallada de estos aspectos, enfocados desde la perspectiva de la Psicología, se puede consultar en la Unidad Formativa 3. Técnicas de comunicación con personas dependientes en instituciones del Módulo 4 de este Manual.

Los profesionales pueden encontrarse con residentes que presenten problemas de comunicación de diferentes tipos como, bien sean adquiridos por la edad (perdida de visión y audición, por ejemplo) o bien adquiridas por un ACV (accidente cerebrovascular) o un accidente o por algún tipo de deterioro cognitivo (demencias, Alzheimer…):

En estos casos la transmisión de información al usuario puede resultar incompleta si el profesional no está suficientemente informado y formado para llevar a cabo una comunicación eficaz con este tipo de individuos.

En todo caso, la comunicación y la transmisión de información serán adaptadas al usuario, sus características y necesidades.

DIFICULTADES O AFECCIONES EN ALGUNO DE LOS COMPONENTES DEL LENGUAJE:

Los problemas de comunicación se relacionan con dificultades o afecciones en alguno de los siguientes componentes del lenguaje: componente motriz, componente cognitivo o componente sensorial. En función del componente afectado, el profesional de atención sociosanitaria podrá utilizar diferentes sistemas, métodos o lenguajes que faciliten la comunicación con estos usuarios. Estos sistemas son conocidos como Sistemas Alternativos y Aumentativos de Comunicación (SAAC).

La Sociedad Española para el Desarrollo de Sistemas de Comunicación Aumentativos y Alternativos (ESAAC) define los sistemas aumentativos de comunicación como aquéllos que complementan o sustituyen el lenguaje oral. El lenguaje oral es el sistema de comunicación más común, pero no es el único. Existen otras opciones, sistemas o estrategias que se pueden utilizar para interaccionar con el entorno y modificarlo. Fotografías, pictogramas, gestos y/o lenguaje escrito son algunas de estas opciones, son algunos de los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación y su propósito no es otro que el de apoyar y estimular la producción oral, teniendo como objetivo la retirada paulatina de dichos apoyos a medida que las destrezas orales se afianzan.

El objetivo de estos sistemas es ofrecer la posibilidad de una expresión significativa, instaurando o ampliando los canales de comunicación de las personas con alteración o imposibilidad del habla. Mejorar el desarrollo de la comunicación y favorecer el desarrollo de la autonomía personal y social y el aprendizaje funcional, son algunos beneficios de los usuarios de estos sistemas.

Todas las personas comunican. Comunicar es más que hablar; son miradas, gestos, sonidos y emociones que nos descubren el interior de las personas. Hay que confiar en las posibilidades comunicativas de las personas y aprender a escucharlas.

Por ejemplo entre estos tenemos

- El conjunto de símbolos Widgit Rebus: hay 8,000 símbolos que están ligados a una base de datos que incluye más de 26,000 palabras. También existen traducciones del vocabulario en muchos otros idiomas. La colección de símbolos de Widgit Rebus está disponible en color y en blanco y negro. Los símbolos Widgit Rebus están diseñados para la comunicación a distancia, ya sea en papel, por correo electrónico, en avisos, etc. Por ejemplo:



El color rojo (el gris en la versión blanco y negro) se utiliza para señalar la parte del dibujo que se quiere expresar:



- El PECS (Sistema de Comunicación por Intercambio de Imágenes) la persona con grandes dificultades en el uso de lenguaje expresivo aprende a comunicarse espontáneamente utilizando símbolos de objetos o actividades deseadas.

  Para iniciar el acto comunicativo, la persona sólo tiene que coger el símbolo del objeto / actividad deseada y dársela al interlocutor para que se produzca el intercambio. Estas tarjetas se archivan de forma personalizada en un libro o tablero, con el cual el usuario de PECS se comunicará allá donde vaya.

  Los símbolos se intercambian para iniciar una petición, hacer una elección, proporcionar información o responder.

- el sistema Bliss, lenguaje gráfico que consta de símbolos pictográficos e ideográficos, así como otros símbolos clasificadores e indicadores que permiten combinaciones para crear nuevos significados. Los símbolos se agrupan por categorías diferenciadas por diferentes colores (verbos, nombres, etc.). Este sistema se usa con personas con discapacidad motriz para el habla, sobre todo en usuarios con parálisis cerebral.

- el sistema SPC (Símbolos Pictográficos para la Comunicación), que aporta un lenguaje de tipo visual para usuarios que no pueden hablar, escribir o leer o tienen dificultad para hacerlo pero que tienen unas capacidad cognitivas mínimas.



Está constituido por símbolos pictográficos y dibujos sencillos agrupados por categorías que se diferencian por colores según la función que realizan. Así, por ejemplo, los verbos se presentan en color verde, los sustantivos en amarillo, etc.

- existen otros muchos sistemas, para más información www.esaac.org

DIFICULTADES O AFECCIONES EN LA VISTA:

Según las pautas indicadas por la ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles) en la comunicación con personas invidentes o con deficiencias visuales debemos tener en cuenta que cada individuo es único y la deficiencia visual debe ser considerada como una característica o condición más de esa persona. Además, las diferencias individuales en cuanto a grado de deficiencia visual, aptitudes personales, nivel de autonomía, etc., hacen que cada persona tenga niveles diferentes de funcionamiento. Por eso, el lo referente a la comunicación debemos:

- Hablar en un tono normal, despacio y claro. No gritar o elevar la voz, las personas con deficiencia visual, en general, oyen perfectamente.
- No sustituir el lenguaje verbal por gestos, pues estos, en muchos casos, no podrán ser percibidos por la otra persona.
- Ser específico y precisos en el mensaje, a fin de no confundir o saturar a la persona.
- No utilizar palabras como “aquí”, “allí”, “esto”, “aquello”... ya que van acompañadas con gestos que no pueden verse por la persona. En estas situaciones es preferible utilizar términos más orientativos como “a izquierda de la mesa”, “a tu derecha”, “delante de la puerta”, “detrás de ti”. En ocasiones, puede ser también útil conducir la mano de la persona hacia el objeto e indicarle de lo que se trata.
- Utilizar normalmente las palabras “ver”, “mirar”, etc.; no considerarlas como términos tabú pues las propias personas con ceguera y deficiencia visual las utilizan normalmente en sus conversaciones.
- Evitar exclamaciones que pueden provocar ansiedad a la persona tales como “¡ay!”, ”¡ay!”, “cuidado”, etc., cuando veamos un peligro para ella (una puerta abierta, un obstáculo en la acera, etc.). Es preferible emplear una exclamación más informativa, como “alto”, con el fin de evitar que siga

avanzando y explicarle después, verbalmente, el peligro o ayudarle para que pueda evitarlo.

- Hablar dirigiendo nuestra mirada a su cara.
- Dirigirse directamente a la persona con deficiencia visual para saber lo que quiere o desea y no al acompañante.
- Utilizar el nombre de la persona, si se conoce, para que tenga claro que nos dirigimos a él.
- Presentarse, identificarse con el fin de que la persona sepa con quien se encuentra, por lo que deberemos decirles nuestro nombre e indicarles, si procede, quienes somos o lo que hacemos. Y por supuesto, en caso de conocer a la persona no jugar a las adivinanzas, ¿quién soy?
- Para saludar, si la persona no extiende la mano, podemos coger la suya para hacerle saber que queremos saludarle.
- Avisar a la persona cuando nos vamos o abandonamos la habitación, de lo contrario puede dirigirse a nosotros pensamos que aún permanecemos con ella. Igualmente, si regresamos es conveniente indicarle nuestra vuelta.
- Indicarle si hay otra u otras personas presentes.
- Comunicar, si es necesario, que se está haciendo o se va a hacer. “Un momento, estoy llamando al encargado”... La vista es un sentido primordial para obtener información. Cuando entramos en un edificio, esperamos para obtener una información o un servicio, etc., no necesitamos en general una información verbal para saber si se nos atiende o se nos ha visto e incluso si hay alguien a quien dirigirnos.

La ONCE también indica una serie de recomendaciones para presentar textos impresos accesibles a personas con deficiencia visual pero el sistema más conocido para usuarios con déficits visuales es el método braille**,** sistema de lectura y escritura táctil basado en las combinaciones de seis puntos en relieve que forman letras, números y signos ortográficos. Puede escribirse de manera manual (con papel especial, punzón, pautas y regletas), con máquina de escribir o con ordenadores conectados a impresoras especiales para braille

Para ampliar información podéis consultar: www.once.es

DÉFICITS AUDITIVOS

Para los dependientes con déficits auditivos, se utiliza el alfabeto dactilológico**,** que es la reproducción de las letras del alfabeto con signos elaborados con las manos, empleado como complemento para el lenguaje de signos.

En www.youtube.com/watch?v=AYLBp9QbaJY tenéis una demostración



Asimismo para transmitir información a los usuarios con discapacidad auditiva es la lectura labiofacial, que consiste en interpretar la lectura de los labios y la cara de la persona con la que nos estamos comunicando.

La palabra complementada *(cued speech)* es otro sistema aumentativo, que consiste en una serie de gestos complementarios a la palabra. Este sistema está formado por el visema (palabra hablada) y el kinema (complemento manual). De este modo, con diferentes gestos se indica al interlocutor qué vocal o consonante se está pronunciando. La palabra complementada suele utilizarse junto con la lectura labiofacial.

El sistema más conocido empleado con personas con discapacidad auditiva es el lenguaje de signos, método complejo de comunicación basado en el movimiento de las manos y de los brazos que va acompañado de expresiones faciales.



En este video podéis ver algunos ejemplos: www.youtube.com/watch?v=EGw-rBm7I2Q

También se ha desarrollado el método bimodal, combinación simultánea entre lenguaje hablado y lenguaje de signos. Aunque se utiliza sobre todo con personas sordas también se puede emplear con residentes que presenten otro tipo de dificultades para la comunicación, especialmente trastornos generales del desarrollo.

CUALQUIER TIPO DE DEMENCIA.

Las personas que padecen demencia se caracterizan fundamentalmente porque presentan importantes problemas de memoria (olvidan rápidamente lo que se les dice; no recuerdan nombres de objetos que sí son capaces de describir; no reconocen u olvidan los nombres de sus familiares o allegados o les confunden; repiten constantemente lo mismo; cuentan historias sin lógica; y sufren problemas para comprender y expresarse).

Una caracterización más completa de este síndrome se expone en el apartado 4.2. Reconocimiento de las características psicológicas de las personas dependientes en instituciones de la Unidad Formativa 1 del Módulo 4 de este Manual.

3.3.- Uso de los indicadores de calidad de las intervenciones.

La Ley de dependencia establece que el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) fomentará la calidad de la atención a la dependencia con el fin de asegurar la eficacia de las prestaciones y servicios En la misma ley se especifica que las instituciones de atención a personas dependientes deberán contar con:

α. Criterios de calidad y seguridad para los centros y servicios.
β. Indicadores de calidad para la evaluación, la mejora continua y el análisis comparado de los centros y servicios del Sistema.
χ. Guías de buenas prácticas.
δ. Cartas de servicios, adaptadas a las condiciones específicas de las personas dependientes, bajo los principios de no discriminación y accesibilidad.

La misma ley indica que en la prestación de los servicios:

1. Se establecerán estándares esenciales de calidad para cada uno de los servicios.
2. Los centros residenciales para personas en situación de dependencia habrán de disponer de un reglamento de régimen interior, que regule su organización y funcionamiento, que incluya un sistema de gestión de calidad y que establezca la participación de los usuarios, en la forma que determine la Administración competente.
3. Se atenderá, de manera específica, a la calidad en el empleo así como a promover la profesionalidad y potenciar la formación en aquellas entidades

que aspiren a gestionar prestaciones o servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Para reforzar este modo de actuación a través de la ORDEN ESD/1984/2008, de 4 de julio, se crea la Comisión Especial para la mejora de la calidad del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

La calidad de la atención a la dependencia hace referencia a que los servicios, atenciones e intervenciones que se realicen con los individuos atendidos satisfarán sus necesidades. Es un concepto subjetivo, pues cada usuario tiene un concepto de calidad diferente en su mente.

La calidad tiene que ser gestionada dentro de la institución de atención a la dependencia. Bajo este concepto se incluyen el conjunto de actividades que efectúa una institución para conseguir, asegurar y mejorar la calidad de sus productos y servicios.

El proceso implica:

1.- Elaborar un plan de actuación

Crear la sistemática de funcionamiento, esto es, acordar protocolos de actuación consensuados iguales para todos los profesionales sociosanitarios dotándolo de los recursos económicos, humanos, técnicos y de otro tipo, deben estar definidos de forma estable y circunstancial.

2.- Realizar un control de calidad

El control de calidad se basa en efectuar actuaciones de seguimiento y medición para controlar los parámetros de calidad. Para definir la calidad de un servicio o una intervención en concreto, se utilizan tres parámetros:

8.1. Los criterios de calidad son las características que deben tener la actividad o el servicio para que sea de calidad, es decir, para lograr la satisfacción del usuario. Los criterios, como objetivos que son, tendrán que ser claros y comprensibles para poder ser entendidos por todo el mundo, flexibles para poder ser modificados y de fácil cuantificación para poder ser medidos. Para definir los criterios de calidad, se partirá de las necesidades que se detecten en la institución, así como de las expresadas y manifestadas por los dependientes, bien verbalmente bien a través de cuestionarios de satisfacción.
8.2. Los indicadores de calidad son una medida cuantitativa que se utiliza para evaluar los criterios de calidad. Por ejemplo alarmas, cambios de absorbentes, número de UPP, número de caídas, etc. en un determinado periodo de tiempo. Los resultados de dichas anotaciones indicarán si se están cumpliendo correctamente los criterios que la institución se ha marcado como criterios de calidad.

8.3. Los estándares de calidad hacen referencia al nivel en que se cumple un criterio de calidad, y son unos márgenes mínimo y máximo entre los que puede moverse un indicador. Si el indicador está entre esos márgenes, se cumple con el criterio de calidad. Normalmente se utilizan porcentajes para definir estos estándares y no deben ser del 100 % porque siempre pueden surgir incidencias no controlables y no por ello se estará dejando de cumplir el criterio de calidad.

3.- Una acreditación y certificación del sistema de calidad.

Existen una pluralidad de estándares de gestión de la calidad normalizados, es decir, definidos por un organismo normalizador, como ISO, DIN o EN, etc. que permiten que una empresa con un sistema de gestión de la calidad pueda validar su efectividad mediante una auditoría de una organización o ente externo. Una de las normas más conocidas para gestionar la calidad, es la norma ISO 9001 (última revisión ISO 9001:2008). En ocasiones, dependiendo del tipo de empresa y de la complejidad de su sistema de gestión, se utiliza un sistema integrado para la gestión de la calidad, el medio ambiente (según norma ISO 14001) y la seguridad, (según norma OHSAS 18000).

4.- Mejora continua del sistema

Establecer los modos de actuación para tras extraer las oportunas conclusiones para una mejora continua del sistema. Esto se lleva a cabo llevando un exhaustivo control del cumplimiento de los indicadores y realizando encuestas de satisfacción para mejorar los criterios de calidad.

Asimismo, el sistema de gestión de la calidad incluirá los siguientes documentos:

- Política y objetivos de calidad: es un compromiso por parte de la institución, una declaración formal de intenciones en materia de calidad que debe ser expuesto en el tablón de anuncios del centro.
- Manual de calidad: en él se incluyen todos los documentos de calidad del sistema, y tiene que estar a disposición de todos los trabajadores para su consulta.
- Procedimientos y protocolos de actuación: éstos han de describir la actividad que afecte a la calidad del servicio. Es necesario que estén a disposición de todos los trabajadores para que conozcan cómo deben actuar en cada caso.
- Registros o formatos de calidad: son documentos que cumplimentan los trabajadores con la información sobre los usuarios. Se utilizan para verificar que una actividad se ha realizado y son fundamentales para el análisis y la mejora continua del sistema. Los registros o formatos de calidad son de gran relevancia y, por este motivo, todos los trabajadores deben saber cómo cumplimentarlos adecuadamente.
- Otros documentos: el sistema de gestión puede incluir otros documentos relacionados con la calidad como, por ejemplo, planes, normas o legislación.

Para garantizar la calidad, además de la certificación por una empresa autorizada, existen dos determinantes que la institución de atención a personas dependientes ha de cumplir:

- Por un lado, contar con profesionales competentes y bien formados en atención a la dependencia, conocedores de las guías de buenas prácticas desarrolladas por instituciones especializadas en la materia o por la propia Administración pública
- Seguir los requisitos marcados por la Administración pública en materia de control de calidad y de recursos humanos.

Asimismo, la institución de atención a la dependencia deberá contar con un reglamento de régimen interior, un documento de carácter interno que tiene que ser conocido por todos los profesionales y usuarios del centro, y que recoge las normas de funcionamiento y organización de la institución, los derechos y deberes de la institución y de los ingresados, el régimen disciplinario (circunstancias para perder la condición de usuario), los horarios, los precios, las normas de admisión, etc.

4. Colaboración en el plan de cuidados individualizado y la documentación básica de trabajo

4.1.- Plan de cuidados individualizado.

El plan de cuidados individualizado es el conjunto de acciones coordinadas realizar por parte del equipo interdisciplinar sobre un a misma persona usuaria, sobre una selección y aplicación de las actividades tipo establecidas o protocolizadas en el Plan de Cuidados General o Estándar del centro, adecuado a las circunstancias individuales de cada persona usuaria en un momento determinado. Busca coordinar las actuaciones no solo en los tratamientos a aplicar, sino también procura educar para la salud, frenar el deterioro y lograr su mejoría global como persona individual y diferenciada.

Elementos constitutivos

El plan de cuidados individualizado se va conformando de forma paulatina a medida que se desarrolla el proceso de atención a los usuarios, el cual tiene las siguientes fases:

1. Valoración.
2. Diagnóstico.
3. Planificación.
4. Ejecución.
5. Evaluación.

En la VALORACIÓN juegan un papel fundamental la observación, la entrevista y la exploración física, ya que van a permitir al profesional la recogida de información de datos subjetivos (expresados por el usuario) y objetivos (observables y medibles por el profesional), que se ordenarán con la ayuda de instrumentos[70] tales como el Modelo de las

14 Necesidades Básicas de Virginia Henderson para evaluar el nivel de dependencia para la realización de actividades de la vida diaria o el Resident Assessment Instrument (RAI) para la valoración de la dependencia funcional

Con los resultados de esa valoración se realiza en las reuniones del equipo interdisciplinar el DIAGNÓSTICO según:

- *Problemas*, a través de etiquetas, como: alimentación, deglución, incontinencia, de úlceras por presión, inmovilismo, caídas, estreñimiento, déficit de autocuidado, deterioro de la movilidad física, insomnio, restricciones físicas o farmacológicas, hipertensión, frecuencia cardíaca, glucemia, temperatura, deterioro cognitivo, etc.
- *Etiología* para describir la posible causa o raíz de los problemas.
- *Signos y síntomas* para establecer las características que apoyan la identificación de ese problema.

El equipo, formado por los Responsables de las diferentes áreas asistenciales del centro (Trabajo social, enfermería, medicina, psicología y fisioterapia), deberá realizar una valoración integral de la persona usuaria, realizar el diagnóstico en el momento de su ingreso. Tras los cual surgirá la propuesta de PLAN DE CUIDADOS INDIVIDUALIZADO GENERAL INICIAL de ese residente.

El equipo técnico interdisciplinar deberá reunirse en sesiones periódicas (normalmente semanales) para la elaboración de el PLAN DE CUIDADOS INDIVIDUALIZADO final. De tratarse otros temas, se levantará la correspondiente acta de reunión, que recogerá la temática, acuerdos, duración y las firmas de los asistentes a la sesión.

Se establecen los objetivos y se elabora el plan de cuidados en función de tres pasos fundamentales:

- Priorización de problemas a intervenir, según su importancia.
- Jerarquización y cuantificación de objetivos para hacer evaluable el plan de cuidados.
- Determinación de actividades para tratar la causa de los problemas o intervenir sobre el propio problema.

Los apartados de este plan son:

1. Plan de cuidados y atención del área social

El/la Diplomada en Trabajo Social, en coordinación con el Servicio de Admisión del centro, se encargará de elaborar la propuesta de intervención social individual de los residentes:

- Asignación de la plaza (habitación, cama, comedor y mesa) que ocupará la persona usuaria de forma temporal o definitiva, procediendo a los cambios de habitación si las circunstancias lo aconsejan.
- Cumplimentación de la documentación precisa para la gestión y facturación de estancias y gastos.
- Cumplimentación de la documentación precisa para promover la protección jurídica del residente (incapacitación, tutela…).
- Facilitar la información para la firma, por parte del cliente o de sus familiares, del Consentimiento Informado de Tratamiento en el centro, previa propuesta del equipo técnico en reunión interdisciplinar.

La ubicación del residente en el comedor se realizará en coordinación entre las unidades de Trabajo Social, Área Médica y Enfermería. En caso de producirse alguna circunstancia que así lo justifique, la Dirección Medica propondrá a la Dirección del centro, a instancia del equipo interdisciplinar, la asignación y/o el cambio de habitación del cliente, de acuerdo con los criterios de funcionamiento de las respectivas unidades funcionales.

De apreciarse en el usuario una presunta incapacidad para su autogobierno, el área de trabajo Social deberá comunicar dicha situación a la Dirección Médica para que se proceda a la realización de la propuesta de Incapacitación al Ministerio Fiscal, notificando la situación a los familiares y a la dirección del centro mediante los formatos de Comunicado de Incapacitación.

De la misma forma, los cambios de centro y defunciones de residentes en proceso de incapacitación deberán ser comunicados por escrito al Ministerio Fiscal.

2. Plan de cuidados áreas de medicina y enfermería

El Servicio Médico del centro, previa información al usuario (si es persona responsable) o a sus familiares, recogerá la autorización para el tratamiento médico según el Consentimiento Informado, que se archivará con la Documentación Clínica del residente.

El servicio médico de la unidad o centro prescribirá el tratamiento farmacológico que precise el residente, anotándolo en la historia clínica del usuario. Este tratamiento se cursará a la Unidad de Farmacoterapia (cuando exista) y al Servicio de Enfermería, que serán los responsables directos de la preparación y suministro de medicación a cada usuario. Una vez preparado el tratamiento individual, cada responsable archivará el tratamiento administrado.

Para el acopio de los cuidados de enfermería, así como para la realización y seguimiento, se cumplimentará la hoja de Orden de tratamiento farmacológico, de los cuales serán responsables el equipo de enfermería con la supervisión del servicio médico del centro, quedando constancia de los mismos en la historia clínica del residente.

De producirse algún accidente y/o caída, el servicio de enfermería será responsable de la primera evaluación, documentando su intervención, facilitando el servicio médico quien completará la evaluación y dará las instrucciones oportunas.

3. Plan de cuidados y atención de la unidad de psicogerontología

La Unidad de Psicogerontología del centro deberá prestar una atención mental individualizada a cada residente, bien por la propuesta del equipo técnico tras la reunión del Equipo Interdisciplinar y/o bien por motu propio, siempre que las circunstancias del usuario así lo aconsejen.

En cualquier caso, el responsable del área de psicología del centro deberá registrar, en la documentación clínica del Área, los objetivos y acciones del plan de intervención de psicología, asimismo cumplimentará periódicamente el formato Control de Actividad.

4. Plan de cuidados y atención de la unidad de terapia ocupacional

La Unidad de Terapia Ocupacional del centro deberá prestar una atención de terapia ocupacional y una prescripción de ayudas técnicas individualizadas a cada residente, bien por la propuesta del equipo técnico tras la reunión del Equipo Interdisciplinar y/o bien por motu propio, siempre que las circunstancias del usuario así lo aconsejen.

En cualquier caso, el responsable del Área de Terapia Ocupacional cumplimentará el Control de Actividad y lo archivará durante el período de tratamiento, devolviéndolo firmado a la Dirección Médica al concluir su intervención.

El/la responsable de Terapia Ocupacional del Centro deberá registrar, en la documentación clínica del Área, los objetivos y acciones del plan de intervención de terapia ocupacional, asimismo cumplimentará periódicamente el formato Control de Actividad. También se responsabilizará del inventariado de material de su unidad.

Tras la elaboración de Plan de Cuidados individualizado, esta se pone en conocimiento de los profesionales sociosanitarios para su EJECUCIÓN. Se trata de poner en marcha las actividades del plan de cuidados con indicaciones sobre metodologías, responsabilidades y plazos establecidos por los profesionales según las problemáticas detectadas sobre las que se intervendrá.

Como ya se ha mencionado anteriormente, en las reuniones semanales del equipo interdisciplinar se realiza la EVALUACIÓN de los planes individualizados de las personas usuarias y en función de las conclusiones a las que se llegue, se realizaran las medidas correctoras adecuadas a cada persona usuaria.

Profesionales que intervienen.

En el apartado anterior se han ido citando los diferentes profesionales que intervienen, en resumen tenemos a:

- El responsable de la institución
- La Dirección Médica encargada de coordinar las actividades y los planes de cuidados del equipo interdisciplinar.
- EL Equipo Interdisciplinar es quien propone las intervenciones generales del plan de cuidados individuales del usuario y coordina el seguimiento de los mismos.
- El Departamento de trabajo social.
- Los Departamentos de Medicina y Enfermería.
- La Unidad de Psicogerontología
- Unidades de Terapia Ocupacional y Fisioterapia

4.2.- El expediente individual de la persona usuaria. Composición.

El expediente individual es la recopilación de todos los documentos relacionados con el usuario en cuestión: plan individual, seguimientos, evaluaciones, etc., así como con un fichero individualizado de cada usuario en el que se recojan de forma continuada sus principales datos administrativos, sanitarios y sociales, incluyendo copia del contrato individual que especifique las condiciones de la estancia.

El expediente administrativo suele estar ubicado en el despacho del trabajador social o de la dirección del centro, en un armario o archivo cerrado bajo llave. Este expediente incluirá la siguiente documentación:

- DNI
- Tarjeta de la Seguridad Social u otros seguros médicos.
- Fotocopias de pólizas de seguros y del último recibo (seguros de defunción, de accidentes, etc.).
- Datos bancarios para domiciliación de recibos o facturas.
- Sentencia de incapacitación (en caso de incapacitación del usuario) y datos del tutor o representante legal.
- Resolución de reconocimiento de la situación de dependencia, que contendrá el grado y nivel de dependencia del usuario, en caso de poseerla.
- Contrato de admisión del ingresado, en el que aparecerán las condiciones de la estancia del residente y de los servicios que se prestan.
- Historia social del usuario, que incluirá los datos sobre él (edad, nivel de estudios, domicilio anterior, etc.) y sobre sus familiares (datos personales, datos de contacto y parentesco o relación con el residente). Se designará un familiar principal para establecer los contactos y proporcionar información.
- Otra documentación social y administrativa que se vaya generando sobre el dependiente durante el ingreso.

El expediente sanitario suele estar ubicado en el despacho del médico, en armario o archivo cerrado bajo llave, e incluirá la siguiente documentación:

- Informes médicos del estado físico y psíquico del usuario, previos al ingreso.
- Historia médica con la valoración inicial y pautas de actuación.
- Hoja de seguimiento con las actuaciones que se llevan a cabo con el residente, incluyendo los cambios en la medicación o en los tratamientos.
- Plan de cuidados individual.
- Toda aquella documentación sanitaria que se vaya generando sobre el usuario durante el ingreso: pruebas médicas, analíticas, etc.

En el mismo expediente sanitario pueden incluirse las valoraciones e historias de enfermería, fisioterapia y terapia ocupacional. En caso de ubicarse en otro lugar, se velará por la protección de los datos que en ellas se incluyan.

Toda la información relacionada con los dependientes será confidencial y deberá ser protegida, en cumplimiento con la LOPD. Se adoptarán todas las medidas de carácter técnico y organizativo que esta ley establece para proteger los datos administrativos y sanitarios recogidos y evitar su destrucción o pérdida, así como el acceso de personas no autorizadas.

Asimismo, puede que parte del expediente administrativo o sanitario del usuario esté en soporte informatizado. En estos casos, se utilizarán claves de acceso para cada uno de los profesionales, que serán modificadas periódicamente para garantizar la confidencialidad

4.3.- Protocolos de actuación.

Los protocolos de actuación son los documentos que conforman el Manual de Protocolos de Actuación de la institución.

Cada protocolo contienen los siguientes apartados:

- *Objetivo:* razón por la que se realiza una técnica o cuidado, es lo que se desea conseguir en cada procedimiento.

- *Recursos necesarios:* relación de materiales y personal que se precisan para la ejecución de la técnica.

- *Observaciones*: indicación y/o especificaciones a tener en cuenta antes, durante o tras la actuación.

- *Procedimiento:* descripción secuencial de las acciones necesarias para la ejecución de la actuación.

- *Puntos de énfasis:* razones, medidas de seguridad o sugerencias, relativas a una de las acciones de la técnica.

- *Registro:* documento donde debe registrarse la actuación realizada, las observaciones a tener en cuenta o las incidencias si las hubiere.

- *Cuidado del material:* indicaciones *a seguir con el material utilizado al finalizar la actuación.*

Los centros suelen tener los siguientes protocolos de prevención y atención al usuario:

- Acogida y adaptación al centro
- Higiene personal, en cuanto al aseo y técnicas
- Prevención de riesgos e intervención: movilización, úlceras, incontinencia, caídas,
- etc.
- Medicación
- Emergencia sanitaria: actuaciones ante una situación de emergencia sanitaria.
- Comunicación
- Úlceras por presión
- Valoración geriátrica integral
- Traslado y acompañamiento a un centro asistencial
- Gestión de sugerencias y reclamaciones
- Acompañamiento y atención durante el proceso de defunción
- Orientación familiar
- Entrenamiento en estrategias para mejorar la memoria
- Terapias funcionales (rehabilitación funcional, entrenamiento en AVDs, psicomotricidad, gerontogimnasia).
- Terapias cognitivas (orientación a la realidad, psicoestimulación cognitiva y rehabilitación cognitiva).
- Terapias psicoafectivas (grupos terapéuticos, reminiscencia).
- Actividades físico-deportivas
- Animación socio-cultural.
- Terapias socializadoras (ergoterapia, musicoterapia, ludoterapia, grupos de habilidades sociales y de comunicación, tertulias)
- Etc.

En los módulos 2 y 3 se describirán varios protocolos e actuación relacionados con el área sanitaria pero si queréis ejemplos los podéis consultar en la página http://www.inforesidencias.com/programas_protocolos.asp

4.4.- Hojas de incidencia: cumplimentación.

En ella se recopilan datos referentes a las incidencias registradas durante la ejecución de los protocolos de actuación siempre que, la evolución y respuesta de los usuarios a las actividades planteadas en sus correspondientes planes de cuidados individualizados, no fuera la esperada, por ejemplo la observación de

enrojecimiento de la piel en la ejecución de un aseo es una incidencia a anotar pues pone en marcha el protocolo de actuación de prevención de úlceras, una caída, etc.

El registro de incidencias deberá contener información sobre:

- El tipo de incidencia observada.
- El momento en el que se ha producido o detectado.
- Identificación de la persona que notifica la incidencia.
- La persona o profesional al que se comunica la incidencia.
- Observaciones sobre los efectos derivados de la misma o las medidas correctoras aplicadas.

Deberán ser cumplimentadas por el profesional que detecte o presencie la incidencia; frecuentemente, será personal auxiliar de atención directa, de enfermería o de dirección, que avalará la información y observaciones reseñadas con su identificación y firma, así como la fecha, hora y el turno al que pertenece.

Las Hojas de Incidencia deberán hacerse llegar al equipo interdisciplinar a fin de adoptar las medidas oportunas para la intervención o resolución.

La tabla de la siguiente página es un ejemplo de hoja de incidencia

4.5.- Utilización de la documentación sociosanitaria manejada en instituciones de personas dependientes.

En las instituciones sanitarias se manejan dos tipos de documentos, los administrativos y los sanitarios. En ambos casos, en el manejo de toda la documentación que contenga los datos de los usuarios en la institución de atención a personas dependientes, se observará y cumplirá estrictamente la La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, (LOPD) para garantizar la confidencialidad de la información de carácter personal, sanitario y social.

El organismo independiente encargado de velar por el cumplimiento de la LOPD, la Agencia Española de Protección de Datos (en lo sucesivo, "AEPD"), señala que las residencias tratan información de un sector de la población, el de la tercera edad, que "*precisa una especial protección, ya que en muchas ocasiones se encuentran en una situación que les impide conocer y ejercitar sus derechos en igualdad de condiciones*".

Todo el sistema de protección de datos está basado en el principio de que cualquier información relacionada con una persona es susceptible de ser considerada dato personal. Pero, además, existe información que, por su naturaleza, merece un nivel superior de protección. La LOPD define esta información, en su artículo 7, como datos

HOJA DE INCIDENCIAS

FECHA _____

SERVICIO / SECCIÓN: _____

ETIQUETA

Nombre:

habitación:

Incidencias de la vía clínica

Fecha:

Enfermería:

Indique 1. Lo realizado y no planificado, 2. Lo planificado y no realizado y 3. Los sucesos adversos	Firma
Turno de mañana	
Turno de tarde	
Turno de noche	

Ejemplo de hoja de incidencias

especialmente protegidos y parece indiscutible que las residencias, por el propio desarrollo de su actividad, precisan de ciertos datos, especialmente protegidos, de los residentes, como los relativos a su salud. Estos datos exigen una mayor cautela en su recogida, almacenamiento y tratamiento y, en consecuencia, la principal razón por la que esta normativa tiene especial impacto en el ámbito de las residencias geriátricas.

Cualquier organización que disponga ficheros donde se archiven de datos de carácter personal de sus clientes, proveedores, trabajadores, etc., debe notificarlos ante la AEPD. Además de la necesidad de notificar los ficheros creados por dichas organizaciones, será necesario hacer lo propio con cualquier modificación o cancelación de dichos ficheros.

El criterio general establecido por la LOPD para la recogida de cualquier tipo de dato personal, es el del consentimiento informado. En las residencias, los datos de salud (los informes médicos previos a la entrada en el centro, las prescripciones médicas de seguimiento y medicación y los registros obligatorios según la normativa de servicios sociales) deben ser recopilados bajo el consentimiento expreso de su titular. A pesar de esta regla general, el mismo artículo donde esto se establece, ya establece que los datos de salud, podrán ser objeto de tratamiento "cuando dicho tratamiento resulte necesario para la prevención o para el diagnóstico médicos, la prestación de asistencia sanitaria o tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios, siempre que dicho tratamiento de datos se realice por un profesional sanitario sujeto al secreto profesional o por otra persona sujeta asimismo a una obligación equivalente de secreto".

El análisis de esta excepción permite llegar a la conclusión que, debido a que los datos de salud de los residentes son recogidos "para la prevención o para el diagnóstico médicos" y estos son tratados por personal sanitario "sujeto al secreto profesional", no sería necesario el consentimiento expreso de los residentes para el tratamiento de sus datos de salud.

A pesar de esta regla general aplicable, el Código Tipo del ACRA eleva los requisitos exigiendo el consentimiento expreso y por escrito de los residentes, para recabar datos de carácter personal relativos a su salud; el propio Código Tipo entiende otorgado dicho consentimiento, mediante la firma del contrato de prestación asistencial.

Cuando el titular de este dato (el residente), no se encuentra en condiciones de dar dicho consentimiento, el Código Tipo del ACRA define tres posibles situaciones aportando sendas soluciones:

a) El residente está plenamente capacitado para expresar libremente su libertad. En este caso será el propio residente quien actúe en nombre propio en todos los actos de disposición de sus datos.
b) El residente está declarado incapaz por sentencia judicial firme. En este caso, será el representante legal o tutor, quien actúe en nombre del residente.
c) El residente no está declarado incapaz por sentencia judicial firme pero padece algún tipo de demencia. El Código Tipo del ACRA se refiere al artículo 11 del Real Decreto 1332/1994, de 20 de junio, por el que se desarrollan determinados aspectos de la LORTAD y al artículo 18.2 la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía de la persona usuaria y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, para prever la posibilidad que el consentimiento en el tratamiento de los datos del residente, lo otorgue su representante legal.

Con independencia que se determine la necesidad de otorgamiento del consentimiento expreso, sea por escrito o no, según se aplique la LOPD o el Código Tipo del ACRA, en ambos supuestos, los titulares de los datos (o sus

representantes), son acreedores de un derecho de información, lo que convierte a las residencias en deudoras de esta obligación.

La residencia está obligada a informar al residente o a su representante, según proceda de:

- De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información.
- Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas.
- De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos.
- De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
- De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su representante.

Aparte del derecho de información, cualquier persona que entregue sus datos personales a un tercero, se convierte en titular de una serie de derechos, a efectos de garantizar el derecho más general, de conocer el uso que se realiza sobre los mencionados datos.

1. Derecho a solicitar información sobre los datos que está tratando, el origen de dichos datos, las comunicaciones realizadas o que se prevé realizar de los mismos.
2. Derecho a solicitar a la residencia la rectificación o la cancelación de los datos que no se ajusten a la LOPD o, en su caso, aquellos que resulten inexactos o incompletos.

Las residencias, como responsable de los ficheros donde se ubican los datos de los residentes, están obligadas a adoptar "las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural" (artículo 9 LOPD). Las mencionadas medidas de seguridad deben quedar establecidas en el Documento de Seguridad que la residencia deberá elaborar, implementar y mantener actualizado; este documento deber ser accesible por el personal con acceso a datos, que resulta obligado por su contenido.

Por otra parte, al margen de la LOPD, las normas de la legislación sanitaria exigen a los profesionales que traten datos de salud, un deber de secreto sobre la información que conozcan en ejercicio de sus funciones, deber que persiste aún después de finalizar sus relaciones con el responsable del fichero (la residencia).

El Documento de Seguridad de la residencia debe establecer y detallar las funciones del personal en relación a su acceso a los datos personales de forma,

que únicamente accedan a aquellos estrictamente necesarios para el desarrollo de sus funciones laborales. La inclusión de estas obligaciones en el Documento de Seguridad, debe tener su correlación en el diseño de la red informática de la residencia, de forma que técnicamente se limite a los usuarios (los trabajadores), el acceso a datos que no precisen para cumplir con sus obligaciones.

El artículo 11.2 de la LOPD prevé supuestos en los que no será necesario el consentimiento del titular de los datos para proceder a su cesión. A continuación enumeramos las excepciones aplicables a la actividad de las residencias geriátricas:

1. Cuando una ley lo prevea (artículo 11.2.a) y d) LOPD). En este supuesto la cesión de datos quedaría amparada por lo que dispone el artículo 7.4 de Decreto 284/1996 (en Cataluña), donde se dispone que la residencia, en el caso de encontrarse ante un ingreso de un residente, no acompañado de una serie de representantes enumerados en la propia ley, estará obligada a comunicar al juez una serie de datos personales (entre los que se incluyen datos de salud del residente).
2. También se podrán ceder los datos del residente, además de los Juzgados, a los siguientes organismos siempre que una ley así lo prevea: administraciones públicas competentes; Hacienda Pública y al Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas o a los órganos equivalentes en cada Comunidad Autónoma.
3. Cesión de datos de salud para solucionar una urgencia (artículo 11.f) LOPD): el Código Tipo del ACRA, por ejemplo, prevé la cesión de los residentes para estas finalidades, a médicos, hospitales, centros de salud, servicios de ambulancia y trabajadores sociales.
4. Cuando la cesión de datos responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica que implica la conexión del tratamiento con ficheros de terceros (artículo 11.2.c) LOPD). A efectos de ejemplo, incluimos los supuestos que el Código Tipo del ACRA incluye entre esta excepción:
    a. Otras residencias: únicamente para el traslado de expedientes, nunca para finalidades comerciales o publicitarias.
    b. Despachos profesionales o gestorías, bancos siempre que la residencia contrate sus servicios profesionales para el cumplimiento de las legítimas finalidades de los centros y que el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros
    c. Cesiones de datos personales de residentes o familiares a farmacias para la tramitación y facturación de recetas de medicamentos no incluidos en los servicios básicos de la residencia.

Hasta el momento hemos analizado los supuestos en que la residencia se convierte en cedente de los datos personales; en el caso contrario (si la residencia recibe dichos datos) también será aplicable la regla general del consentimiento previo, a menos que no nos encontremos ante una excepción legal. En este supuesto, tal y

como se ha indicado anteriormente, la residencia debería informar a los titulares de los datos, en el plazo de tres meses desde que recabó sus datos de la información señalada en el apartado 1.2 in fine de este artículo. Esta información no sería necesaria si existe una previsión legal por la que la residencia recibe estos datos, en el caso de Cataluña podemos señalar el artículo 7.2 del Decreto 284/1996, que obliga a la residencia a disponer de un informe médico del residente, en el momento de su ingreso donde se contengan sus datos personales y los relativos a su salud.

En el caso que la residencia encargue a un tercero la prestación de un servicio, el desarrollo del cual implique el acceso a datos ubicados en sus ficheros, nos encontraremos ante un supuesto de tratamiento de datos por cuenta de terceros. En este caso, la relación entre la residencia y este tercero debe estar regulada en un contrato escrito donde se establezca que el encargado del tratamiento (el tercero) "únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento (la residencia), que no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en dicho contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas". Adicionalmente el mencionado contrato, deberá contener las medidas de seguridad que el encargado del tratamiento adoptará en sus sistemas informáticos en el tratamiento de los datos, así como la necesidad de destrucción de los mismos, una vez la prestación del servicio haya concluido.

En este supuesto, además de aquellos más conflictivos a los que hemos aludido a lo largo de este trabajo, podemos incluir el caso en que profesionales externos a la residencia accedan a los datos de residentes a los efectos de prestar un servicio de asistencia médica. Adicionalmente al caso de los datos de los residentes, entraría en este supuesto, por ejemplo, circunstancias tan habituales como el encargo a una gestoría de la elaboración de las nóminas del personal de la residencia.

4.6.- Recopilación y transmisión de información al equipo de trabajo y al equipo interdisciplinar.

La comunicación entre individuos de igual estatus (horizontal), entre superiores y subordinados (vertical: ascendente y descendente) y entre personas de distinto estatus ubicados en diferentes líneas de mando (diagonal) constituyen los modos básicos de los flujos de in formación.

- La comunicación descendente se utiliza, en general, para transmitir indicaciones respecto de la tarea, explicar los propósitos, informar sobre normas y procedimientos, enviar feedback a los subordinados o comentar los objetivos, las metas y la filosofía de la empresa.

- La comunicación ascendente, se emplea preferentemente para informar sobre los resultados o efectos de las tareas, las acciones ejecutadas, las opiniones sobre las prácticas y políticas de la organización, necesidades, sugerencias, etc.
- La comunicación horizontal permite la coordinación del trabajo, la planificación de actividades y, además de satisfacer las necesidades

individuales, es esencial para favorecer la interacción de las personas que se encuentran en un mismo nivel y quienes interactúan con otras áreas y desarrollan trabajos en equipo.

- En la comunicación vertical predomina el intercambio de información de naturaleza más formal; mientras que la comunicación lateral y horizontal tiende más a lo informal.

Los canales de comunicación más habituales se recogen en el siguiente cuadro:

DIRECCIÓN	ORAL	ESCRITA
Vertical	***Descendente*** Modo: Directa (cara a cara), reuniones grupales, entrevistas, teléfono,handy, eventos, cursos. Objetivos: información operativa, indicaciones,asesoramiento, etc.	***Descendente*** Medios: E-mail, mensajería electrónica, memos, planillas, circulares, carteleras, manuales, reportes, etc. Objetivos: Información operativa, indicaciones, información de base, asesoramiento, etc
	Ascendente Modo: Directo (cara a cara), Reuniones, entrevistas, teléfono, handy, eventos. Objetivos: responder pedido de información, sugerencias, informar sobre tarea, etc.	***Ascendente*** Modo: E-mails, reportes, memos, circulares, planillas, informes, cartas.
Horizontal	Reuniones, charlas informales, comité, conversaciones cara a cara, teléfono, handy, "radio pasillo".	E-mails, chat, menos, circulares, planillas, reportes, copias, informes, formularios, etc.

Si en la comunicación ascendente no tiene eco en la descendente, si no funciona, repercutirá en efectos negativos: falta de eficiencia en la comunicación que produce ruidos, retarda las correcciones o modificación de decisiones sobre la marcha en los procesos, incremento del número de errores, reducción de la productividad y de la satisfacción, surgimiento de barreras, distorsiones y rumores. Muchas veces los logros se asocian con los incrementos en los intercambios de mensajes (comunicación fluida) y los fracasos con su disminución.

La falta de coordinación, información y de claridad en los mensajes se traducen en "ruidos" que dificultan el desarrollo de las tareas. La utilización de prácticas comunicativas basadas en la "retroalimentación en el desempeño", permite que cada uno de los trabajadores conozca qué opinan sus superiores sobre su desempeño y de este modo realizar ajustes en su tarea que le permitan lograr los objetivos de su área.

La contracara de esta actitud proactiva son los jefes nunca demuestran abiertamente aprobación o desaprobación a la tarea de las personas a su cargo.

En este video tienes un breve resumen de la documentación sociosanitaria
http://www.youtube.com/watch?v=5jTorx9OwA4

ACTIVIDADES UNIDAD

1. Lee detenidamente las frases que a continuación presentamos indica si son verdaderas o falsas corrigiendo las falsas

a. Una persona con autonomía personal mantiene el control de la toma de decisiones sobre su propia vida y puede ejecutar por sí misma las actividades básicas e instrumentales de la vida cotidiana.
b. Las actividades de la vida diaria se pueden clasificar según la OMS (que adoptó la Clasificación Internacional de Funcionamiento, Discapacidad y Salud en 2001) en tres grupos: Movilidad, Autocuidado y Deambulación.
c. La escala de medida más utilizada para valorar las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) es la de Lawton y Brody.
d. En el protocolo escrito se detallan los procedimientos y fases a llevar a cabo por los profesionales del centro para lograr una atención adecuada de las personas usuarias, describiendo los trabajos a realizar por cada área o profesional de intervención.
e. En el registro se deja constancia diaria por escrito del trabajo realizado con identificación del trabajador que lo ha efectuado, sirviendo de documento de control para el equipo interdisciplinar en el seguimiento del correcto desarrollo del plan de cuidados individualizado.

2. ¿Qué información se aconseja transmitir al usuario para motivar su participación en las actividades diarias del centro? Subraya las opciones correctas.

a. Cuándo se va a realizar la actividad
b. Cómo se va a realizar la actividad
c. Es imprescindible informar sobre a y b
d. Dónde se va a realizar la actividad
e. Es imprescindible informar sobre a, b y d
f. Ninguna de las anteriores

3. Completa los siguientes párrafos con las palabras adecuadas.

Entre los objetivos de la labor del _____, está el de trabajar las actitudes positivas de la persona usuaria y _____ para lograr que participe como protagonista y que colabore como estimulador de otros residentes menos participativos.

El _____ además de participar en las actividades establecidas en su _____ podrá participar también en actividades generales de la organización, en actividades de ocio y culturales, en actividades domésticas, etc.

Entre las pautas de actuación a utilizar por el profesional en atención sociosanitaria se encuentra la de utilizar la _____, intentando comprender las causas de la negatividad y la no-participación, apoyando, estimulando y reforzando positivamente al usuario.

Buscar la implicación de otros _____ que expliquen al usuario los beneficios terapéuticos de una actitud participativa e intentar involucrar a los _____ para que les motiven y convenzan de las ventajas de participar en la vida del centro.

4. Describe de forma breve, las recomendaciones que los cuidadores deben tener en cuenta en el acompañamiento al usuario, en su realización de las Actividades de la Vida Diaria (AVD)

5. Relaciona los protocolos que describen las funciones de intervención del profesional en atención sociosanitaria con su correspondiente área de actuación, según la tabla que se expone abajo

	PROTOCOLOS DE INTERVENCIÓN	ÁREAS DE ACTUACIÓN
1	Sexualidad en las personas usuarias del centro.	
2	Prevención y tratamiento no farmacológico del dolor en personas usuarias.	
3	Detección precoz de cambios de comportamiento y anímicos en personas usuarias a través de la observación.	
4	Etiología y abordaje terapéutico de los síntomas frecuentes en personas usuarias enfermas en estado terminal.	
5	Primeros auxilios en situaciones de urgencia con personas usuarias.	
6	Prevención de problemas de espalda en el personal del centro.	
7	Cuidados a los familiares/allegados de la persona usuaria en fase terminal.	
8	Preparación del alta/baja de la persona usuaria	
9	Programa Individual de Cuidados.	
10	Guías/tutores de persona usuaria recién ingresada.	
11	Mantener la confidencialidad de la información personal.	
12	Garantizar la calidad higiénico-sanitaria del Servicio de Restauración	
13	Calidad y circuito en el Servicio de Lavandería.	
14	Maltrato a usuarios.	
15	Funcionamiento del Servicio de Animación Socio-Cultural.	

16	Promoción del sueño y del descanso de la persona usuaria.	
17	Preparación de la persona fallecida.	
18	Desarrollo de estilos de vida saludables y el grado de autonomía personal más positivo en las personas usuarias.	
19	Movilización de la persona usuaria con ayudas técnicas.	
20	Mejora de la comunicación con personas usuarias con limitaciones o problemas.	
21	Prevención del estrés en el trabajo con personas usuarias.	
22	Servicio asistencial que realiza el personal auxiliar de atención directa.	
23	Preparación de la habitación de un nuevo ingreso.	
24	Alimentación y nutrición de personas usuarias en centros.	

ÁREAS DE ACTUACIÓN			
A	Normas de actuación y convivencia.	H	Apoyo en la atención directa de actividades educativas.
B	Apoyo al ingreso de usuarios.	I	Apoyo en la atención directa de cuidados sanitarios.
C	Participación, motivación y protección de derechos de las personas usuarias.	J	Atención a la Conducta y Comunicación de personas usuarias con limitaciones.
D	Alimentación y restauración.	K	Atención directa en cuidados paliativos.
E	Servicio de lavandería.	L	Prevención de riesgos laborales y de salud.
F	Apoyo en actividades socio-culturales.	M	Bajas de personas usuarias.
G	Apoyo en la atención directa para Actividades de la Vida Diaria.		

6. De los siguientes enunciados, ¿cuáles son verdaderos y cuáles son falsos?

- En la realización de las diferentes actividades del centro serán necesarios una serie de materiales que deberán estar organizados y controlados en sus correspondientes almacenes y que pueden ser clasificados en fungibles e inventariables.
- El material fungible es aquél que no sufre un rápido deterioro por su uso, llegando a formar parte del inventario anual del centro. En este caso, se encuentran los bienes materiales, como ordenadores; o bienes inmateriales, como aplicaciones informáticas.

- Entre los problemas a resolver en el control de inventarios se encuentran el exceso de existencias o la insuficiencia de existencias.
- El profesional en atención sociosanitaria debe saber elaborar inventarios de los productos y materiales que se usan habitualmente en la institución
- Según el Decreto 293/2009, existen tres tipos de barreras: urbanísticas, arquitectónicas y periféricas.
- Las unidades de Estancias Dincontinencia urinariarnas son unidades de alojamiento y convivencia ubicadas en edificios o zonas de viviendas normalizadas, destinadas a personas mayores con un grado suficiente de autonomía y supervisadas por una entidad de Servicios Sociales.

8. Enumera las fases del Plan de Cuidados Individualizado y explica brevemente en qué consiste cada una de ellas.